# פורום ברק

## מפגש צוות 'מניעת הדרדרות'

## ג' בניסן, תשפ"ד

## 11 באפריל 2024

**ברוכים.ות הבאים.ות**

# פורום 'ברק'

## הרחבת והעמקת שת"פ בין-מערכתי

## אל מול אתגר הזדקנות האוכלוסייה בישראל

*הזדקנות איננה רק תהליך של דעיכה וחוסר פעילות, זו תקופה של אושר וסיפוק מהחיים בדגש על ממדים של אושר (wellbeing).*

*הזדקנות מיטבית מבדדת בשייכות, בזיקת משמעות לחיים, בשימור תפקוד ובמניעת הדרדרות.*

**שיתוף פעולה רב מערכתי למענה רוחבי לאתגרי הזדקנות האוכלוסייה**

משרד הרווחה והביטחון החברתי; משרד הבריאות; המשרד לשוויון חברתי, הביטוח הלאומי;

מרכז השלטון המקומי; רשויות מקומיות; קופ"ח כללית; מכבי; מאוחדת; לאומית, הג'וינט

במסגרת פורום 'ברק' הוקמו **3 צוותי עבודה** הממוקדים ב- 3 אתגרי ליבה שנבחרו:

1. **מניעת הדרדרות**
2. **דאטה ודיגיטציה**
3. **רשויות מקומיות**

# מטרות צוות זה:

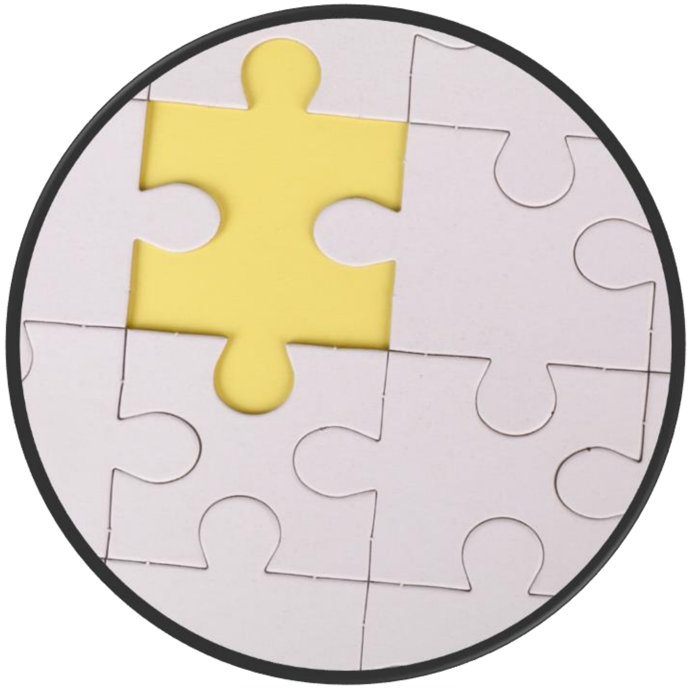
- ✓ לייצר תפיסה רב מערכתית משותפת לתפקוד ומניעה לטובת שימור תפקוד.
- ✓ למפות את השירותים והמהלכים למניעת הדרדרות במערכות השונות - הנוכחיים והמתוכננים.
- ✓ לקדם יישום של התפיסה במערכות השונות ולייצר ממשקים ושיתופי פעולה בין המערכות למניעת הדרדרות.
- ✓ למקד עבודה, חשיבה ופיתוח בנושאי הליבה למניעת הדרדרות (הרחבת שירותים, ממשקים, תמרוצים וכד').

# מטרות מפגש זה:

- ❖ היכרות הדדית בין חברי הצוות כבסיס לשותפויות עתידיות בנושא מניעת הדרדרות
- ❖ תיקוף ודיוק תפיסה רב מערכתית משותפת לשימור תפקוד ומניעת הדרדרות

# היכרות עם האקוסיסטם

# בעולמות מניעת ההדרדרות



# משרד הרווחה והבטחון החברתי

## מינהל אזרחים ותיקים במשרד הרווחה והביטחון החברתי

## שירותים חברתיים למניעת הדרדרות

אביעד יצחקי – מנהל אגף תכנון הזדקנות האוכלוסייה, מינהל אזרחים ותיקים

ורד רוקח – מנהלת שירות מסגרות בקהילה, מינהל אזרחים ותיקים

משרד הרווחה
והביטחון
החברתי

# מטרות העל

היערכות
להזדקנות
שכבר כאן

שימור ושיפור
תפקוד
שייכות
ומשמעות
מניעת
מצבי סיכון

משרד הרווחה והביטחון החברתי

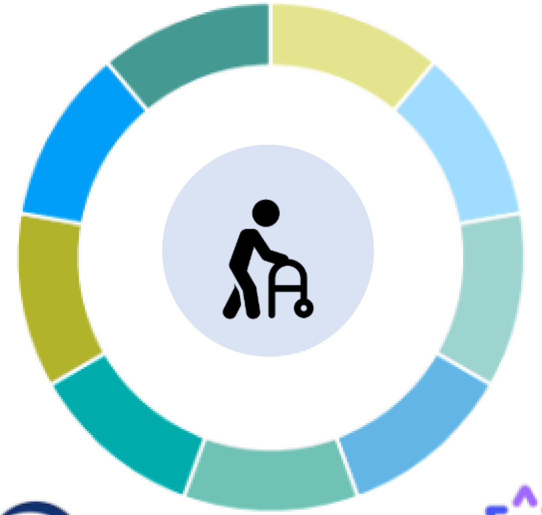
# והאזרח צריך לחפש... האתגר: ריכוזיות, פיצול בין משרדים

**גוף תומך מרכזי**

ג'וינט ישראל אשל

מרכז פיתוח חברתי בשיתוף הממשלה לשיפור איכות החיים של הזקנים בישראל מבחינה פיזית, קוגניטיבית וחברתית, סיוע בשמירה על תפקוד, וקידום הזקנות בקהילה

**הרשויות המקומיות** כגוף תפעולי נותן שירותים



**משרד הבריאות**
- ביטוח בריאות
- סיוע בהתאמת דירות למוגבלים בניידותם
- אשפוז סיעודיים ותשושי נפש
- טיפול לשלב סוף החיים, ופטירה

**משרד האוצר**
תשלום פנסיה תקציבית לגימלאי מדינה

**משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים**

**משרד הרווחה** אמון על מתן מענה לצרכי אזרחים מגיל הפרישה לעידוד הזדקנות בקהילה וכן במוסדות לפי הצורך:
- סיוע בתחזוקת הבית
- מענה לצורך בחברה והגברת תחושת הערך
- סיוע בהנגשת וקבלת שירותים רפואיים
- מימון מגורים במסגרת מוסדית לזכאים
- אכיפת זכויות עובדים זרים בעבודה
- מתן תסקירים לבית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס

**ביטוח לאומי**
- קביעת זכאות לקצבאות כגון: סיעוד, קצבת אזרח ותיק, השלמת הכנסה ועוד.
- ייעוץ אישי וסיוע במיצוי זכויות

**המשרד לשוויון חברתי**
- קידום פנאי ואיכות חיים
- מוקד מידע על הזכויות, וסיוע במיצוין.
- מוקד סיוע מיצוי זכויות בזמן אשפוז בבית חולים

**משרד המשפטים**
- פיקוח על תפקוד אפוטרופוסים
- חוקים, ותקנות, הנוגעים לאנשים עם מוגבלויות
- טיפול בצוואות וירושות

**רשות המיסים**
מתן הטבות מס בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני

**רשות האוכלוסין**
- היתרים על העסקת עובד זר
- ניהול פיקדון מעסיקים לעובדים זרים

## ברמת הפרט - מענה לאזרח הקשיש דורש
## התמודדות מורכבת עם מגוון רחב של אתגרי חייו

בדידות

קניות

מיצוי זכויות

תרופות

פעילות ותנועה

הזנחה

דיור

הכנסה

עזרי התניידות

חברה

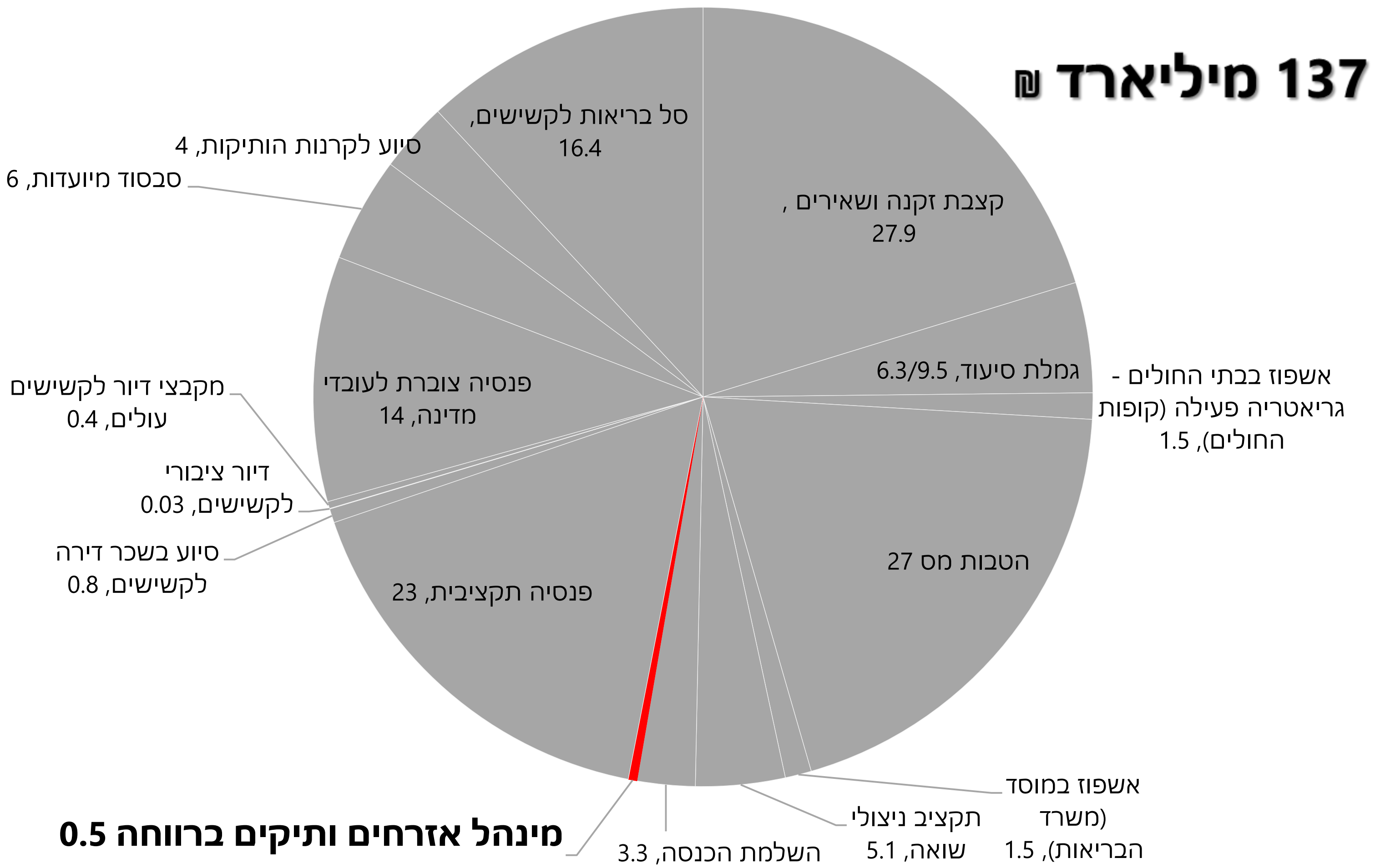
ניקיון

תחבורה

משפחה

שירותים רפואיים

## התפלגות התקציב באחוזים:



# שירותים חברתיים למניעת הדרדרות

- מועדונים חברתיים
- קהילה תומכת
- מרכזי יום
- מועדוני מופ"ת ומועדונים מועשרים
- שירותים לניצולי שואה
- מועדוני תעסוקה
- תכניות לבני משפחה מטפלים
- שירותים להפגת הבדידות
- בתים חמים
- מניעת התעללות והזנחה
- תוכנית למרותקי בית
- רווחה מרחוק
- תמך מקצועי
- מוקד שייכות
- בתי אבות
- נופשונים
- קהילה לדורות
- תיאום טיפול
- סיוע חומרי
- פיקוח על הדיור המוגן

משרד הרווחה
והביטחון החברתי
חוסן חברתי לישראל

# במספרים:

**180 מרכזי יום**
14,000 משתתפים

**380 מועדוני מופ"ת**
13,000 משתתפים

**1000 מועדונים חברתיים ובתים חמים**
35 אלף משתתפים

**400 קהילות תומכות**
80 אלף משתתפים

**334 תכניות**
להפגת בדידות

**1000 תקני כ"א ברשויות**
800 עו"ס זיקנה
200 רכזי מענים

## ב-200 אלף מקבלי שירותים בישראל

**משרד הרווחה והביטחון החברתי**

# תפיסת המענים

- **הזדקנות בקהילה (Aging In Place)** לאפשר לאזרחים הוותיקים להישאר בסביבתם המוכרת והביתית ככל הניתן, תוך דאגה למעטפת של מענים תומכים בכל היבטי החיים.
- **הזדקנות מיטבית:** שמירה על בריאות איתנה; פעילות המייצרת משמעות ושייכות; הבטחת חוסן כלכלי.
- **משמעות ושייכות:** טיפוח ופיתוח תחושת המשמעות והגברת השייכות החברתית תוך הרחבת והעמקת הרשתות החברתיות של הפרט, הגברת תחושת השייכות למרחב מגוריהם המשפחתי, הקהילתי והפיזי, והגברת המעורבות החברתית קהילתית.
- **ביזור סמכויות לרשויות המקומיות** באמצעות גמישות תקציבית
- **ללכת לצד מקבל השירות**

משרד הרווחה
והביטחון החברתי

# השירותים במינהל

1. אגף קהילה.
2. אגף מערכי דיור.
3. הגנה מפני מצבי סיכון.
4. "חרבות ברזל."

משרד הרווחה
והביטחון החברתי

# קהילה

**קהילות תומכות:**

**346 קהילות תומכות ב- 179 רשויות:**

**41,700 בתי-אב מושמי רווחה (30% זוגות).**

**כ- 5,200 בתי-אב זכאי חוק סיעוד, מופנים דרך ביטוח לאומי.**

**כ- 80,000 אזרחים ותיקים משתתפים בקהילות התומכות.**

**מועדונים:**

**"בתים חמים": כ- 200 בתים חמים, הנותנים מענה לקבוצה של עד 15 מבקרים.**

**מועדונים חברתיים: כ30,000 לקוחות בכ-700 מועדונים ברחבי ישראל.**

**מועדונים מועשרים: 3,449 מושמים ב- 101 מועדונים הפועלים ב- 78 רשויות מקומיות.**

**מועדון מופ"ת: 12,383 מושמים ב- 236 רשויות המפעילים 354 מועדונים (לאוכלוסייה הכללית ולשורדי שואה).**

**מועדוני תעסוקה: כ- 600 מבקרים ב- 18מועדוני תעסוקה.**

משרד הרווחה
והביטחון החברתי

# אגף קהילה – המשך

**מרכזי היום:**

183 מרכזי יום בהם מבקרים למעלה מ- 14,000 אזרחים ותיקים.

רוב התקציב מגיע מגמלת הסיעוד של המטופלים.

**תיאום טיפול:** בהחלטת ממשלה 3379, הוחלט על יציאה לדרך עם תכנית תיאום טיפול. 30 רשויות עם 50 צוותי מתאמים במסגרת מחלקות הרווחה ובשיתוף קופ"ח כללית, מכבי ומאוחדת.

**רשת מקומית:** 26 רשויות מקומיות, 8 מהן רשויות מהחברה הערבית עבור כ- 8,000 משתתפים/ות.

- לתכנית שני מודלים: "**קהילה לדורות**", מודל מורחב הפועל באזור גיאוגרפי ובמרחב המקוון, ו"**רשת מקומית**" – מודל צר המשלב פלטפורמות פרונטליות עם אוריינות דיגיטלית וקשר מרחוק.

# קהילה - המשך

**סיוע חומרי:** הסיוע מיועד לכלל האזרחים המוכרים למחלקת הרווחה אשר מתקשים לכלכל את עצמם או את משפחתם.

**מענים לבני ולבנות משפחה מטפלים:** כיום פועלות כ- 100 מחלקות בתחום בני משפחה מטפלים ברשויות המקומיות.

**סמך מקצועי:** ליווי אישי וכוללני על פי תוכנית שנקבעת ע"י עו"ס המחלקה.

**רווחה מרחוק** 118 רשויות 3,500 אזרחים ותיקים משתתפים.

משרד הרווחה
והביטחון החברתי

# קהילה – המשך

**הגנה מפני מצבי סיכון**

**היחידות למניעת התעללות והזנחה:** כיום פועלות 155 יחידות ב- 120 רשויות מקומיות ברחבי הארץ. בשנת 2022 טופלו ביחידות מעל 10,000 מקרים. **טרם נתקבלו נתוני 2023**.

**מערך ארצי של עו"ס לחוק הגנה על חוסים** כ- 21,000 מקבלי שירות.

בשנת 2022 היו כ- 11,800 התערבויות במסגרת חוקי ההגנה.

**עו"ד יד:** במהלך שנת 2023 היו 228 פניות של אזרחים וותיקים לתכנית.

**תכנית מז"ל :** 69 אזרחים וותיקים משתתפים בפעילות המתקיימת בחמש רשויות מקומיות.

משרד הרווחה
והביטחון החברתי

# מערכי דיור

**בתי אבות:** 3,355 מושמים ב- 86 בתי-אב.

**נופשונים:** מענה קצר מועד. 570 מושמים (לא כולל בזמן מלחמת "חרבות ברזל").

**דיור מוגן:** מערכי דיור פרטיים.

המינהל מבצע רגולציה לכ- 100 בתים ובהם כ- 15,000 דיירים/ות.

משרד הרווחה
והביטחון החברתי

# "חרבות ברזל"

1. מלונות.
2. נוהל מוגנות במלחמה.
3. סל מענים  עבור חטופים ששבו.
4. קליטת אזרחים ותיקים בדיור מוגן ובתי אבות.

משרד הרווחה
והביטחון החברתי

# מה בתכנית להמשך?

**<u>תפקוד ומשמעות:</u>**

**קול קורא למועדונים ומרכזי היום לפיתוח תוכניות עם משמעות ושייכות – בהובלת קרן הסיעוד**

**<u>מניעת סיכון:</u>**

**הכנסת שימוש שאלון if – risk** – שאלון למילוי עצמי של גורמי מקצוע עבור מקבלי שירות

**פיתוח מענים ליום שאחרי –** בקהילות תומכות, מרכזי היום, מועדונים, מלונות, פסיכוסוציאלי

משרד הרווחה
והביטחון החברתי

# עקרונות מנחים במודל העבודה המשותף:

מענה אוניברסלי רחב

תיעדוף מענה חברתי רחב על מענה פרטני

תמרוץ שירותים חברתיים

שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות למענה לכלל הזקנים ברשות

הזדקנות בקהילה ודחיקת המיסוד

מנטל לנכס- קידום זקנה פעילה

קידום מניעה, הגברת השייכות ודחיקת התלות

תשתיות דאטה לתכנון והתאמת השירותים

חליפה אישית לכל לקוח

גמישות מרבית במתן השירותים

ראיה מערכתית של האזרח הוותיק ומשפחתו

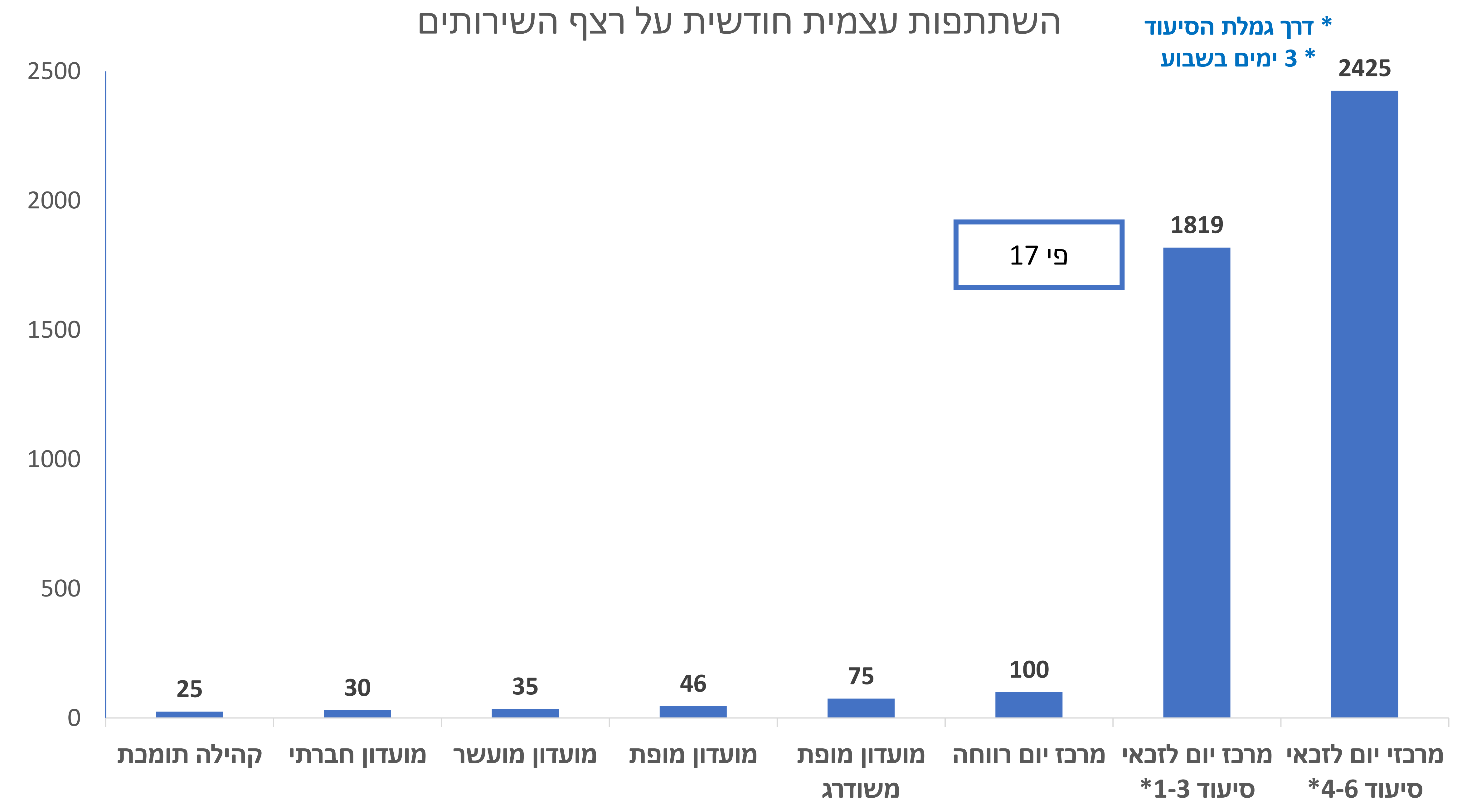
משרד הרווחה והביטחון החברתי
חוסן חברתי לישראל

המוסד לביטוח לאומי

## ניתוח חלופות כיום

| המרכיב | מטפלת | כסף | מרכז יום |
|---|---|---|---|
| 2 שעות סיעוד | כ-40 דק' (נלקחות שעות) | 96 ש"ח | 6 שעות |
| הסיוע | עזרה בבית/ ניקיון | כספי | מפגש חברתי, חוגים, הסעה, גורמי מקצוע וטיפול: עו"ס, פיזיותרפיה, מדריך |
| מחקר על דחיקת תלות | משתנה בין מקרים, לא נמצא כמועיל, טענות כמגביר תלות | לא רלוונטי | מוכח במחקר בארץ ובעולם כמועיל ודוחק תלות |
| הכשרות והדרכות | בשוליים | לא רלוונטי | קיימת הכשרה מקצועית ושוטפת |
| פיקוח | פיקוח מורכב על כ140 א' מטפלות בבתים | לא רלוונטי | קיים פיקוח מקצועי שוטף |
| הנגישות | משאב במחסור גורר תלות במטפלת | קל להעברה | יתרון משמעותי לגודל (180 מרכזים, לא בכל הארץ) |
| המצב בפועל | 73% מהגמלאות | 24% מהגמלאות | 2% מהגמלאות |

# אז מה באמת ידחוק את התלות?


השתתפות עצמית חודשית על רצף השירותים
* דרך גמלת הסיעוד
* 3 ימים בשבוע
2500
2000
1500
1000
500
0
2425
1819
פי 17
100
75
46
35
30
25
מרכזי יום לזכאי סיעוד 4-6*
מרכז יום לזכאי סיעוד 1-3*
מרכז יום רווחה
מועדון מופת משודרג
מועדון מופת
מועדון מועשר
מועדון חברתי
קהילה תומכת

# תמונת המצב בסיעוד

| סוגיות: | |
|---|---|
| כסף | לאור האפשרות לקבל כסף בעין- כיצד לתמרץ את הוותיקים לצרוך שירותים דוחקי תלות? |
| מטפלות | טיפול בית – משאב במחסור, למי נועד הסיוע ומה הערך שטיפול בבית ייתן לו? |
| שירותים | כיצד לשפר את המענים הניתנים לזכאי סיעוד לצורך שימור תפקוד ודחיקת תלות? |

משרד הרווחה והביטחון החברתי

# איך נדע שהצלחנו?
## מדידה והערכה

**הרחבת מעגל המבקרים**

**הרחבת ההפניות**
ביטוח לאומי, קופ"ח ומחלקות לשירותים חברתי

**הרחבת מעגלי השייכות והמשמעות**
השתתפות בעיסוקים מגוונים ובקהילות משמעות

**שימור ושיפור התפקוד**
עיכוב ההתדרדרות והתלות

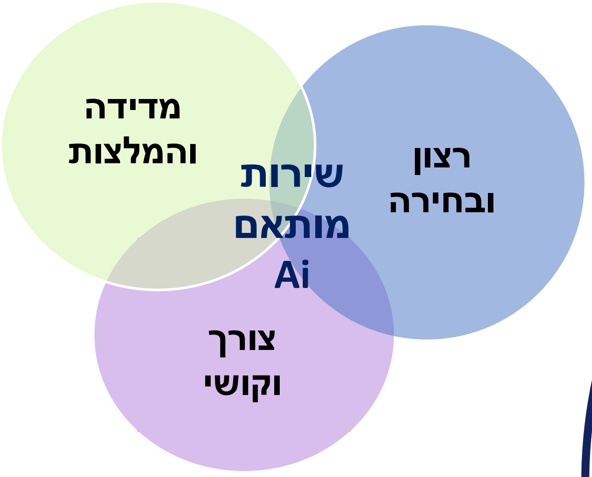
**הפעלת רצף שירותים**
מרכז אופק, מועדון מופ"ת, קהילה תומכת, קתדרה, מרחב התנדבות ועוד.

**הרחבת פעילות**
המרכז עד הערב

**הרחבת השתתפות האדם המבוגר בעשייה**
**זקנה פעילה**

**הפעלת שירותי קידום בריאות במרכזים**
(דרך טופס 17)

# החזון: סל אישי מותאם אישית מבוסס נתונים



**רשת שירותים –**
מעטפת שירותים
לבחירת האזרח הוותיק

משרד הרווחה
והביטחון החברתי

תם הזמן

NEXT...

# משרד הבריאות

## האגף לגריאטריה

# מהלכים ותוכניות למניעת הדרדרות -2024


ד"ר רויטל גרוס נבו

מנהלת המחלקה לשירותי קהילה

אגף גריאטריה משרד הבריאות

אסנת שמיר

רכזת תחום גריאטריה

המחלקה הארצית לפיזיותרפיה

# צעדים למניעת הדרדרות

# מניעת הדרדרות – צירי פעולה

## הזדקנות מיטבית

- מניעה במרפאות הראשוניות
- קידום בריאות ואיתור מוקדם בקהילה ובמרחב המקומי
- המרחב אזורי (אשכולות ורשויות)
- בני משפחה מטפלים
- מבחן תמיכה מתכלל  לקופות ( הערכות גריאטריות וכו)

## התאמת השירותים

- מרחב הבית כחלופת אשפוז
- חיזוק האשפוז ההמשכי – גריאטריה פעילה
- התאמת בתי חולים לאוכלוסיה המזדקנת
- חיזוק מערך השיקום באשפוז ובקהילה

# מניעת נפילות

## המטרה: ירידה בשיעור הנפילות בזקנים

נפילות הן אחת מהבעיות השכיחות בגיל המבוגר ומהוות גורם משמעותי לירידה תפקודית ואשפוז במוסדות גריאטריים.
חלק גדול מהנפילות ניתנות למניעה.

התוכנית תפתח אמצעי הדרכה ולומדות בתחום מניעת נפילות להכשרת מטפלים, מתנדבים ובני משפחה.

המשך שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי לצורך הרחבת התוכנית של "בית בטוח" לרשויות מקומיות נוספות

## משימות מרכזיות:

פיתוח "קיט הדרכה" על דרכים למניעת נפילות ואופן יישומן.

בניית תהליך הפצה והטמעה של ערכת ההדרכה למתנדבים העובדים עם זקנים

בשיתוף עם ביטוח לאומי- הוצאת קול קורא להרחבת תוכניות ל"בית בטוח" לרשויות מקומיות נוספות.

דיוק מבחן התמיכה בנושא מניעת נפילות לצורך חיזוק ההתערבויות למניעת נפילות.

# מניעת הדרדרות זקנים באשפוז- מית"ב

המטרה: הקטנת שיעור ההידרדרות של זקנים בעת אשפוז

משימות מרכזיות:

זקנים רבים סובלים מהידרדרות תפקודית בבתי החולים.

התוכנית תיתן שירות ממוקד לזקן במסגרת אשפוז בבתי חולים כלליים.
התוכנית

- תסייע במניעה מפני הידרדרות
- תעודד הולכה ושמירת תפקוד.
- מניעה, איתור וטיפול בדליריום.
- פיתוח והרחבה של שירותים גריאטריים בבית החולים הכללי במסגרת תכנית רב-שנתית.

חשיבות התוכנית במתן שירות ממוקד לזקנים, במטרה לשמור על תפקוד ואיכות החיים.

הפעלת תכנית מניעת הידרדרות ע"י מבחן תמיכה המשכי – פיקוח על עמידה ביעדי המבחן בבתי החולים המשתתפים

הסדרת מערכת מיחשוב

כתיבת מבחן המשך על בסיס תובנות מהמדידה

# חיזוק היקף ההון האנושי הרפואי בבתי החולים הגריאטרים

המטרה: הנגשת הערכה גריאטרית כוללנית ובניית תוכניות טיפול ייעודיות למניעת הדרדרות

משימות מרכזיות:

קיים מחסור בגריאטריים שצפוי להחמיר לאור הזדקנות האוכלוסייה

התכנית

- תאפשר הגדלת ההון האנושי העומד לרשות המר"גים ע"י גיוס מתמחים מעבר לתקינה.
- תשפר את איכות הטיפול בזקנים ועל ידי הערכה כוללנית והתאמת תוכנית טיפול ייעודית, תתרום למניעת הדרדרות.

הגדלת מספר המתמחים בגריאטריה באמצעות מבחן תמיכה

גיוס מתמחים לשם הגדלת מספרם

תם הזמן

NEXT...

# קופת חולים כללית

***קידום בריאות ומניעת הדרדרות בקרב קשישים***

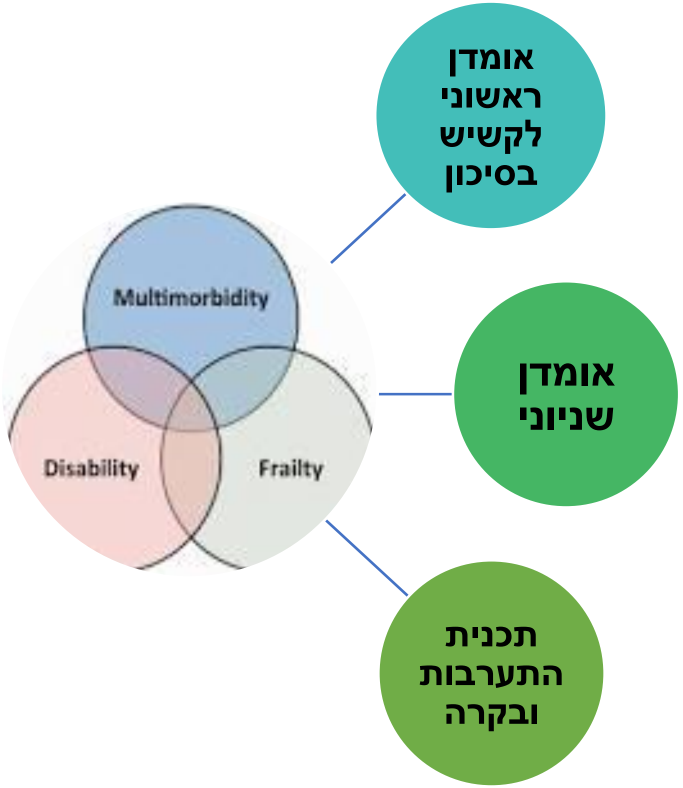
ד"ר שי בריל, גריאטר ראשי
דלית ציפל, ראש תחום טיפול בזקן ובחולה הכרוני

# קידום בריאות ומניעת הדרדרות בקרב קשישים

ד"ר שי בריל – גריאטר ראשי
דלית ציפל – ראש תחום זקנה ומחלות כרוניות

**<u>תכניות לדחיקת תלות, דחיקת תחלואה, אורח חיים בריא</u>**

- ✓ קשיש בסיכון להידרדרות – איתור קבוצת אוכלוסייה בסיכון ופעילות יזומה – DM
- ✓ קשישים ניידים בעזרת הזולת
- ✓ קשישים מרותקים
- ✓ קשישים בסיכון לאשפוז חוזר
- ✓ קידום בריאות ואורח חיים בריא (פ. גופנית, שימור זיכרון, דמנציה, תזונה, שינה, התאמת בית, טיפול תרופתי, עישון )
- ✓ איזון תחלואה כרונית
- ✓ רפואה מונעת (בדיקות וחיסונים)
- ✓ רצף טיפול בית חולים קהילה
- ✓ שיקום ביתי
- ✓ יחידות לטיפול בית
- ✓ טיפול מרחוק
- ✓ התאמה תרבותית ומגזרית
- ✓ שיתופי פעולה: עיריית ירושלים, קידום אורח חיים בריא



# כיווני המחר בכללית – כבר בעשייה

- ✓ פיתוח והטמעת מודל ניבוי CPI (AI)

  מערכת ממוחשבת אשר תסרוק את תיק המטופל לשם איתור ותיעדוף מטופלים

  מבין מבוטחים עצמאיים או מקבלי גמלת סיעוד ברמה 1 ו-2

  אשר ימצאו בסיכון להידרדרות ואשפוז והתערבות יזומה
- ✓ שילוב טכנולוגיות דיגיטליות לטיפול וניטור מרחוק
- ✓ שילוב טכנולוגיות חדשניות לטיפול
- ✓ הרחבת מערך יחידות לטיפולי בית : מגמה עולמית במיקוד הטיפול בקהילה והעדפת מטופלים להישאר בביתם,

  קליטת יותר מטופלים, טכנולוגיות רפואיות שמאפשרות טיפול ביתי
- ✓ התאמת מערכות מחשוב ותשתיות (מערכת Geographic Information System - GIS)
- ✓ מפות טיפוליות ממוחשבות לתיק רפואי

# תם הזמן

# NEXT...

# קופת חולים מכבי

ד"ר זוריאן רדומיסלסקי,

מנהל גריאטריה ארצי ויו"ר ועדת התמחויות

# מצב קיים
# חשיבה לפיתוח

ד"ר זוריאן רדומיסלסקי
מנהל גריאטריה ארצי
מערך רופא ראשי
2024

מכבי
קבוצת הבריאות הטובה בישראל

# הזדקנות תקינה - מערכות שונות באדם

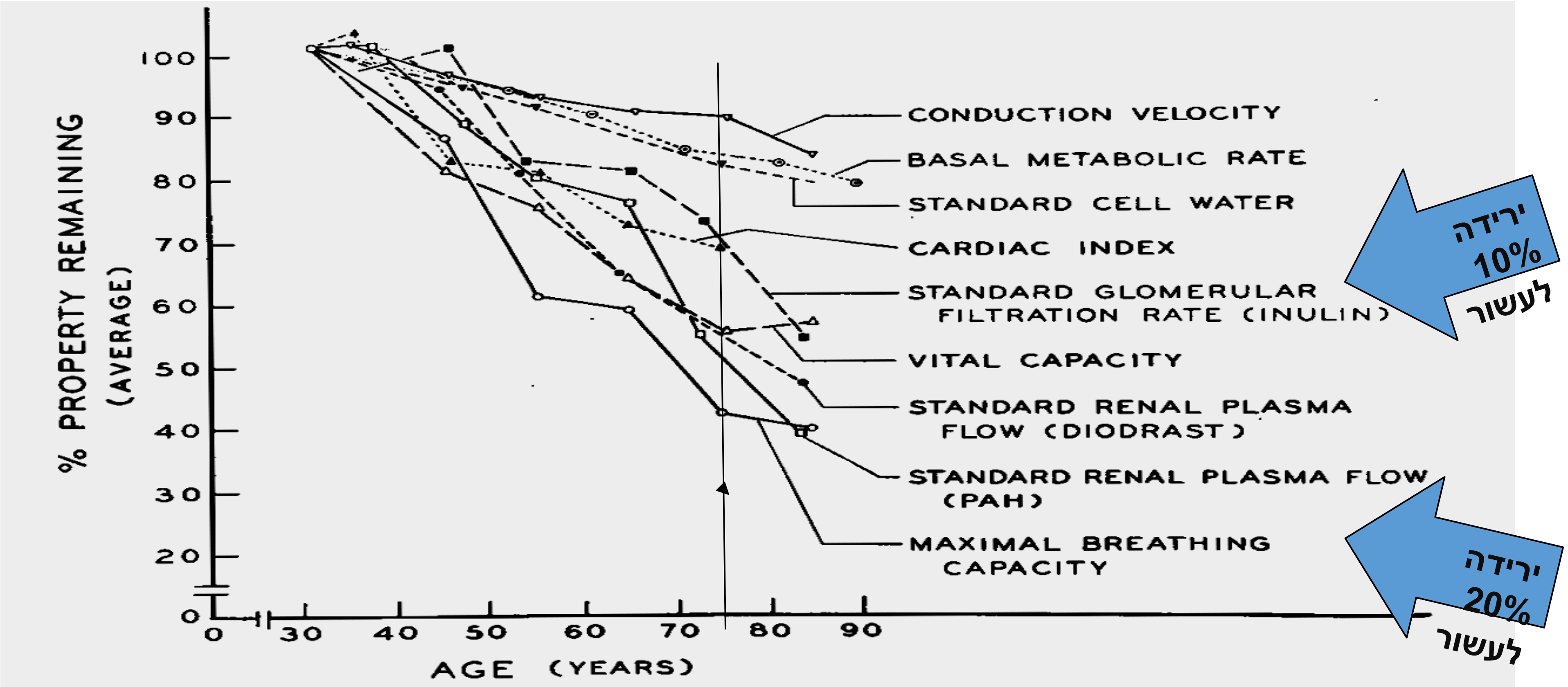


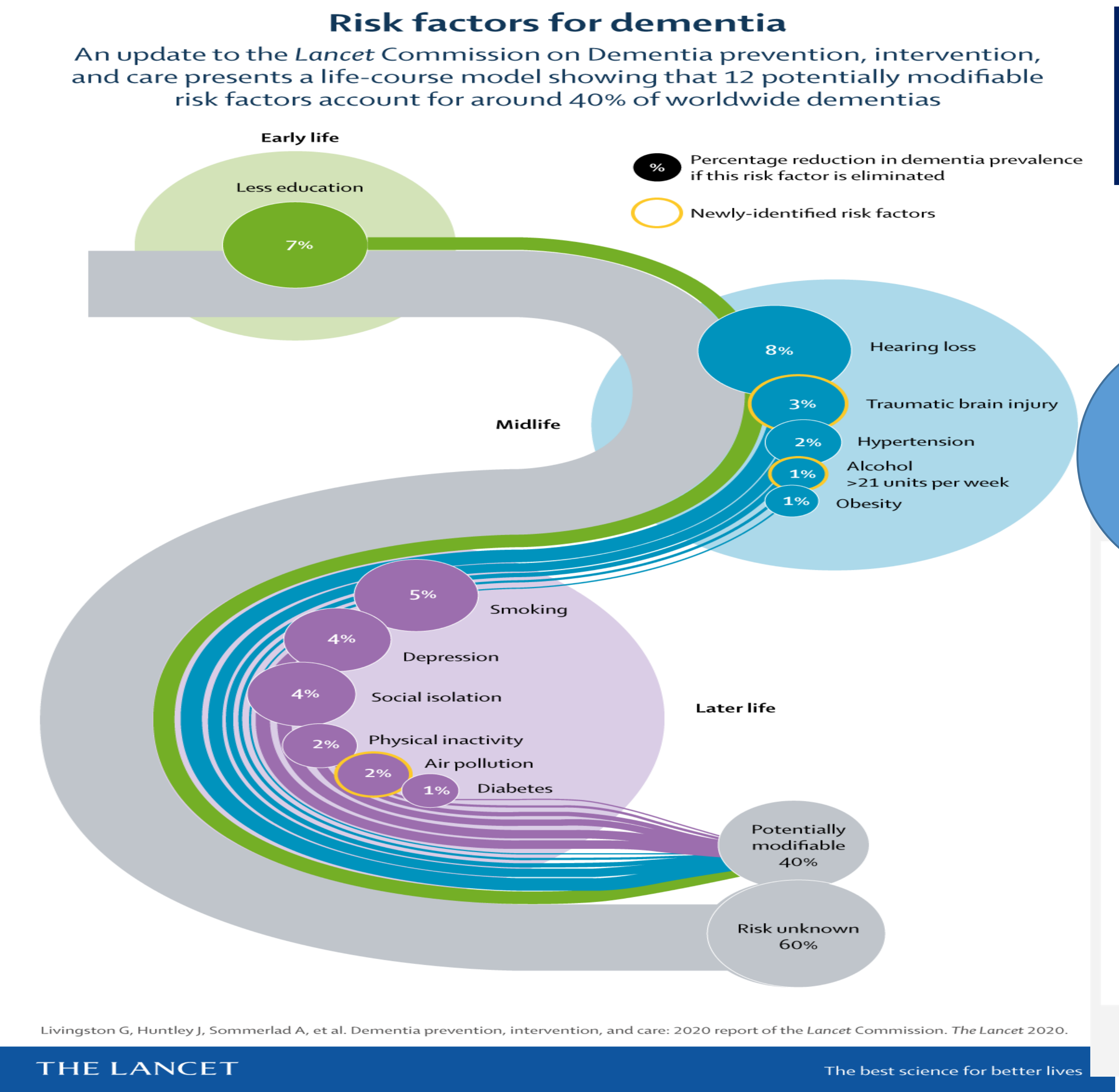

Fig. 17. *Composite diagrams of the per cent of various (human) functional capacities or properties remaining at various ages. Data from Shock and collaborators (from Strehler, ref. 10).*

**ירידה בתפקוד מערכות שונות – כפונקציה של הגיל**

# COGNITIVE CHANGES WITH AGING

| Field | Subtype | | Naming | Dementia |
|---|---|---|---|---|
| **General intelligence** | Fluid | Solve novel problems | ↓ 55 | ↓↓ |
| | Crystallized | Knowledge & access | Δ 85 | ↓ |
| **Attention** | Sustained | | ↓ | |
| | Selective | | Δ | |
| **Language** | Spont.prod | | ↓ | |
| | Lexical | Recognize word | Δ | |
| | Phonologic | Spelling | Δ | |
| **Memory** | ST/working | | Δ | |
| | LT/second. | | Δ / ↓ | ↓↓ |
| | Remote | | Δ | |
| **Visuospatial** | | | ↓ | ↓↓ |
| **Psychomotor** | | | ↓ | ↓↓ |
| **Executive** | | | Δ | ↓↓↓ |

# דוגמא לאפשרות למנוע התדרדרות קוגניטיבית:




מודעות

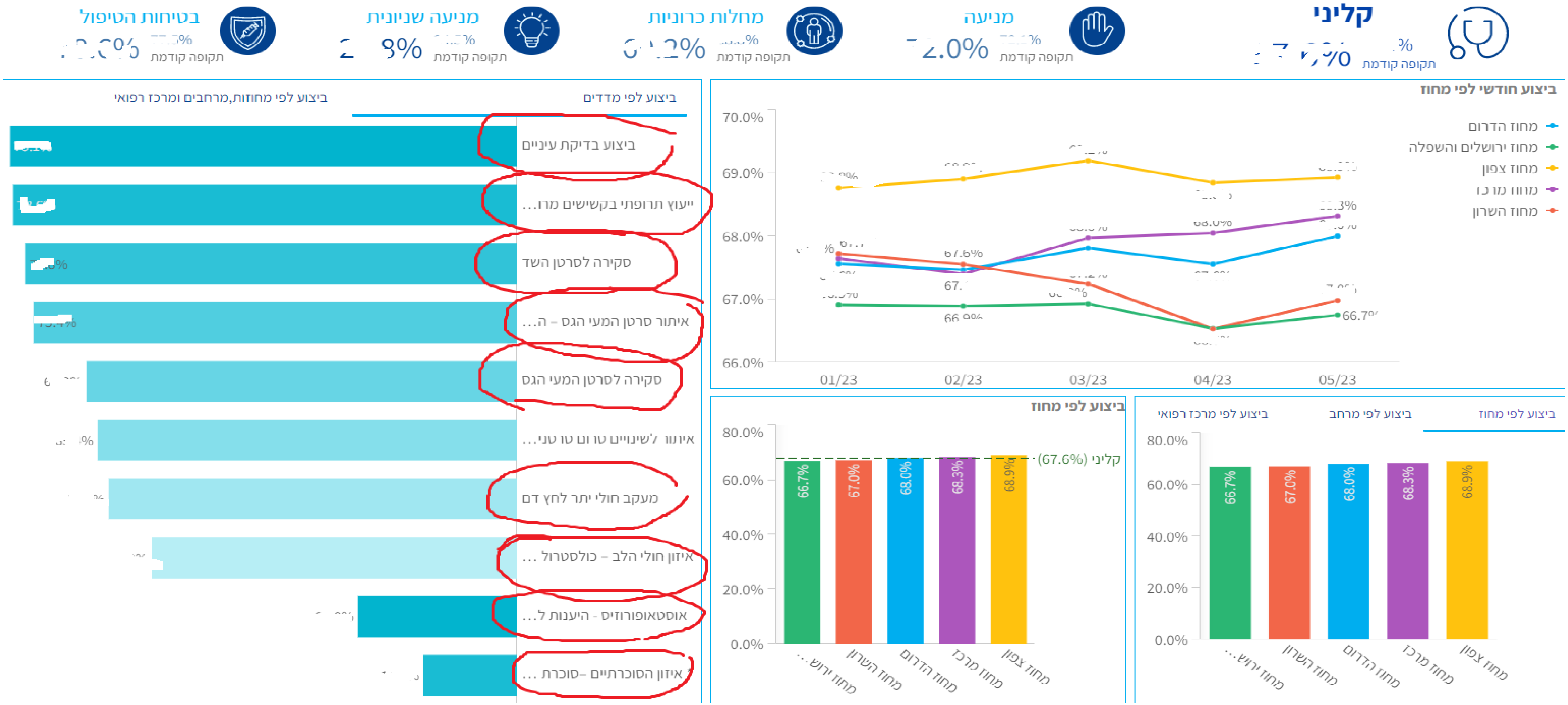
מניעה מערכתית וחברתית

איתור מוקדם

# כלים קיימים היום

מכבי
שירותי הבריאות הטובים בישראל

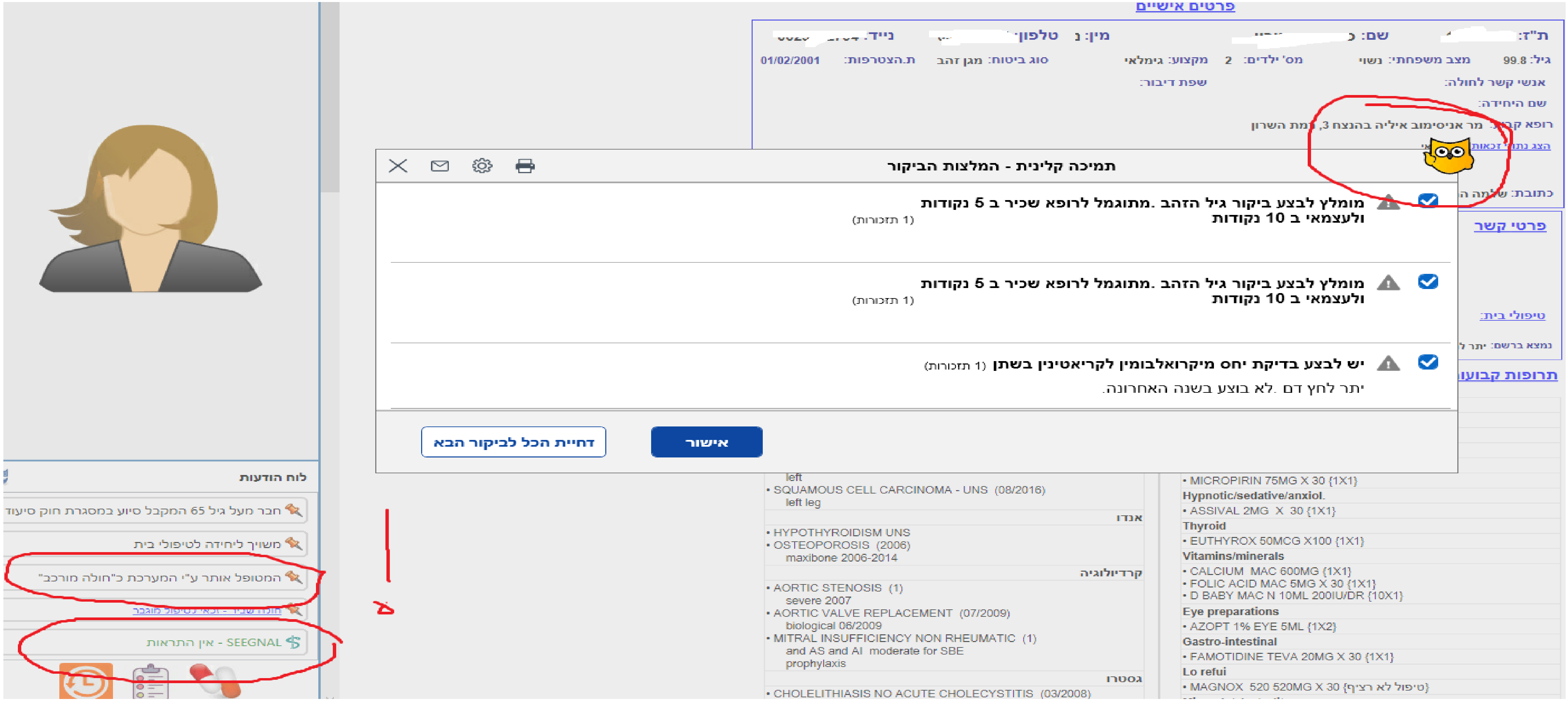
# HVA



קליני
תקופה קודמת
מניעה
תקופה קודמת
מחלות כרוניות
תקופה קודמת
מניעה שניונית
תקופה קודמת
בטיחות הטיפול
תקופה קודמת
ביצוע חודשי לפי מחוז
מחוז הדרום
מחוז ירושלים והשפלה
מחוז צפון
מחוז מרכז
מחוז השרון
70.0%
69.0%
68.0%
67.0%
66.0%
01/23
02/23
03/23
04/23
05/23
ביצוע לפי מדדים
ביצוע לפי מחוזות,מרחבים ומרכז רפואי
ביצוע בדיקת עיניים
ייעוץ תרופתי בקשישים מרו…
סקירה לסרטן השד
איתור סרטן המעי הגס – ה…
סקירה לסרטן המעי הגס
איתור לשינויים טרום סרטני…
מעקב חולי יתר לחץ דם
איזון חולי הלב – כולסטרול …
אוסטאופורוזיס - היענות ל…
איזון הסוכרתיים– סוכרת …
ביצוע לפי מחוז
קליני (67.6%)
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
66.7%
67.0%
68.0%
68.3%
68.9%
מחוז ירוש…
מחוז השרון
מחוז הדרום
מחוז מרכז
מחוז צפון
ביצוע לפי מחוז
ביצוע לפי מרחב
ביצוע לפי מרכז רפואי

# תיק אחיד – מידע כרונולוגית
# רביזיה תרופות

# מערכת חוכמה רפואית
# מערכת SEGNAL
# הגדרת חולה מורכב



# הגדרה אחידה- מורכבות תפקודית

| ציון | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| **גיל** | 50-65 | מתחת ל-65-75 | 75-85 | 86 + |
| **מספר מחלות כרוניות** | | עד 2 | 2-4 | מעל 4 |
| **אשפוזים חוזרים** | | אשפוז 1 בשנה שעברה | 2-4 | מעל 4 אשפוזים או פניות למיון |
| **ריבוי תרופות** | | עד 5 | 6-8 תרופות | מעל 8 |
| **תרופות מגבירות סיכון** | | | עד 1 תרופות מקבוצה | יותר 2 תרופות |
| **מצב תזונתי-** | | | אלבומין נמוך/ אובדן משקל מעל 5% ב- 3 חודשים/ שימוש במזון ייעודי BMI נמוך מ-23 | אובדן משקל מעל 10% ב- 3 חודשים |
| **תפקוד קוגניטיבית** | | MCI | דמנציה עד 3 שנים | דמנציה יותר מ3 שנים |
| **מצב תפקודי** | | נדחי חוק סיעוד 7680, 7681 | 7678 זכאים עד 77, רמה 1-3 | סיעודי 7671-73 זכאים 4-6 |
| **נפילות** | אין סיכון | אין סיכון, אך נמצא ברשם OP | סיכון בינוני | סיכון גבוה |
| **עלות שנתי** | | מעל X אלף ₪ | מעל X+1/2X אלף ₪ | מעל 2X אלף ₪ |
| **סטטוס סוציואקונומי SES** | גבוה | | בינוני | נמוך |

מביאים את רפואת העתיד. מהר!
הטיבת הבריאות

**סה"כ ציון מקסימלי32**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| דר' רותם | בת | מטפל עיקרי | | 0502298228 |

נמצא ברשם: לב וכלי דם, אוסטאופורוזיס, טרום סוכרת

## תרופות קבועות

מרשמים בתוקף

**Cardio/vascular**
- AMIODACORE 200MG X 30 {1X1}

**Antithrombotic agents**
- PRADAXA 110MG X 60 {1X2}

**Diuretic**
- ALDACTONE 25MG X 20 {1X1}

**Vitamins/minerals**
- CALCIUM +D400 600/400X60 {1X2}

**Eye preparations**
- LIVOSTIN EYE 0.05%X4ML {1X3}
- AZOPT 1% EYE 5ML {1X3}
- DUOTRAV BAK FREE 2.5ML {1X3}

**Antidementia**
- RIVASTIGMIN 9.5 13.8MG X30 {1X1}

גאנט קבועות | גאנט מופסקות

## בעיות ידועות

**קרדיולוגיה**
- ATRIAL FIBRILLATION (08/2019)
- HYPERTENSION ESSENTIAL UNS (10/2019)
  suspected

**נפרולוגיה/אורולוגיה**
- RENAL FAILURE UNS Acute (03/2020)

**פירוט נתוני חולה מורכב** X

**ציון מורכבות כולל: 13** (טווח 1-19, 19=מורכב ביותר)

קבוצת גיל

מספר מחלות כרוניות

ריבוי תרופות

תרופות מגבירות סיכון

אשפוזים חוזרים

דמנציה

עישון: לא-27/11/2019

BMI: (10/2019) 26.8

משקל: 46

## ביקור רופא אחרון

שם הרופא:ד"ר גנקין אינה

אבחנה:

DEMENTIA UNS

תאריך ביקור:25/12/2019

## ביקורי אחות אחרונים

תאריך הביקור: 06/01/2022

שם אחות: פגוסיאן ילנה

תחום הטיפול: אחות

טיפולים:

חיסון קורונה שעות נוספות (אחות) חבר

תאריך הביקור: 05/08/2021

שם אחות: כתב ורדה

תחום הטיפול: אחות

טיפולים:

ביקור בית רגיל מחוץ לשעות העבודה

הערכת תפקודית ADL

תאריך הביקור: 04/08/2021

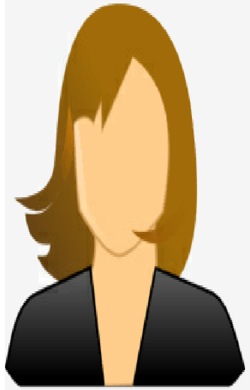
שם אחות: מזיבוביץ' לוי

- דף המכורות - לעיניי בכבו
- **פרטים אישיים**
- **רישום ביקורים**
- **ביקורי רופאים במכבי**
- **ט.בית/גריאטריה/מצפן- רופא**
- מיון וקבלה
- **מצפן/ גריאטריה-דיון צוות**

שירותי הקהילה

ביטוח לאומי

- **הוראת רופא/טיפול תרופתי- קהי**
- **מדדים ואומדנים**
- **תשאול אלימות**
- **טיפולים / ניתוחים**
- אומדני גיל הזהב
- **אנמנזה**
- **אשפוזים**
- **אחות קש"ב-אשפוז**
- קשר מוקד רב תחומי לרופא
- **תרופות קבועות**
- **הפקת תרופות קבועות**
- **תרופות מופסקות**
- תרופות קבועות-פירוט
- **מעבדות**
- תוצאות תרבית
- **בדיקות מיוחדות**
- בריאות הנפש - ביה"ח ומכונים
- **מרפאות חוץ ומכונים**
- **בדיקות במכונים**
- **ייעוצים**
- **בקשות/תשובות זימות**
- הפניה לזימות
- צהל- תקציר תיק
- עבודת צוות



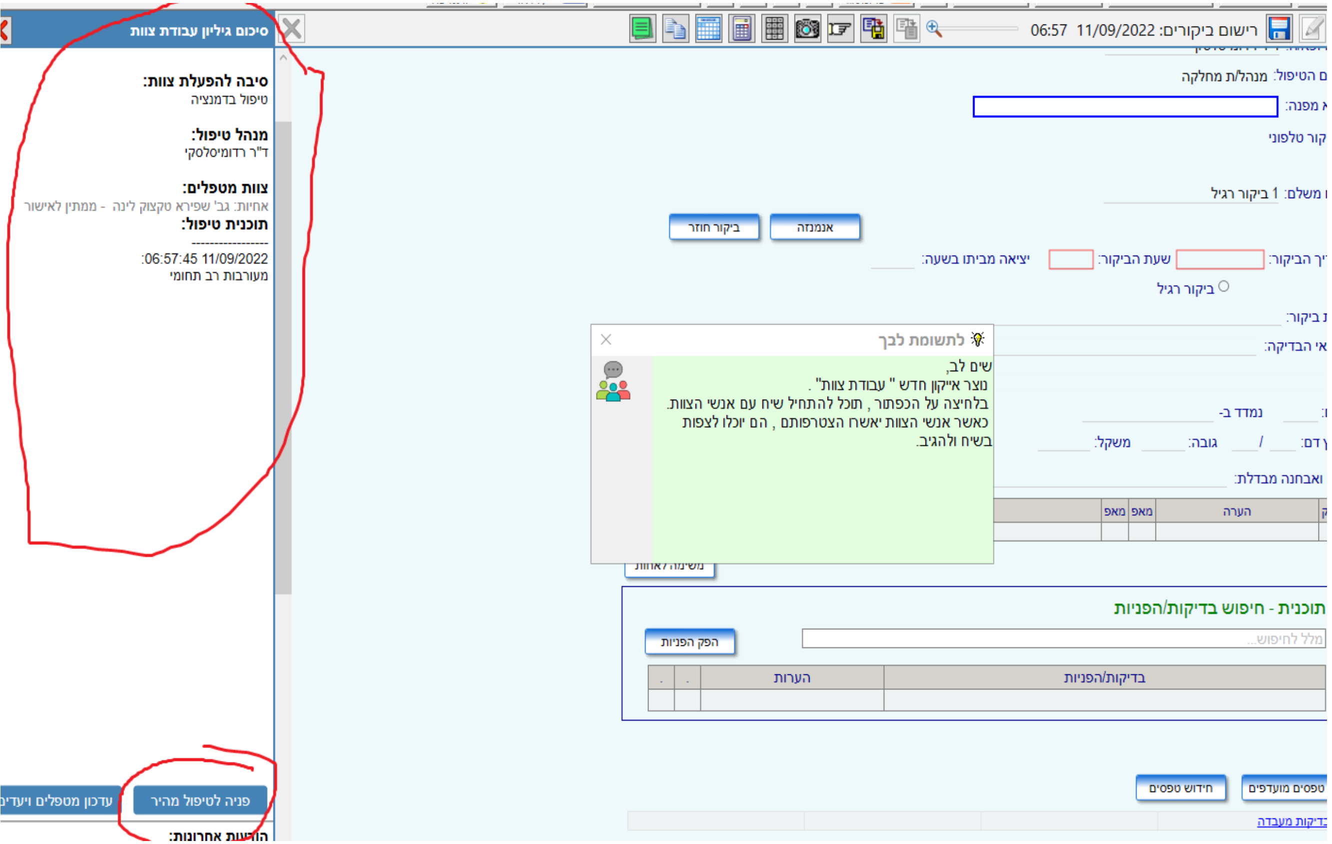
**לוח הודעות**

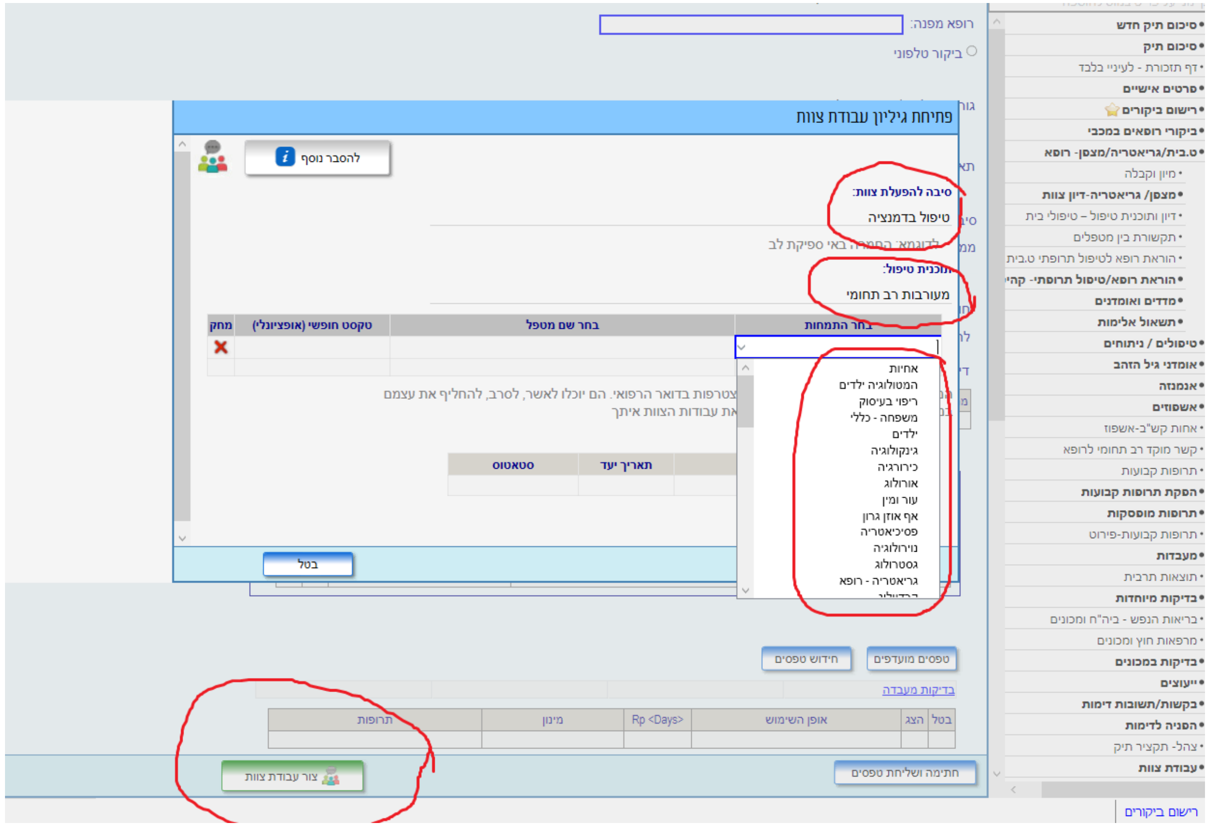
ניצול/ת שואה

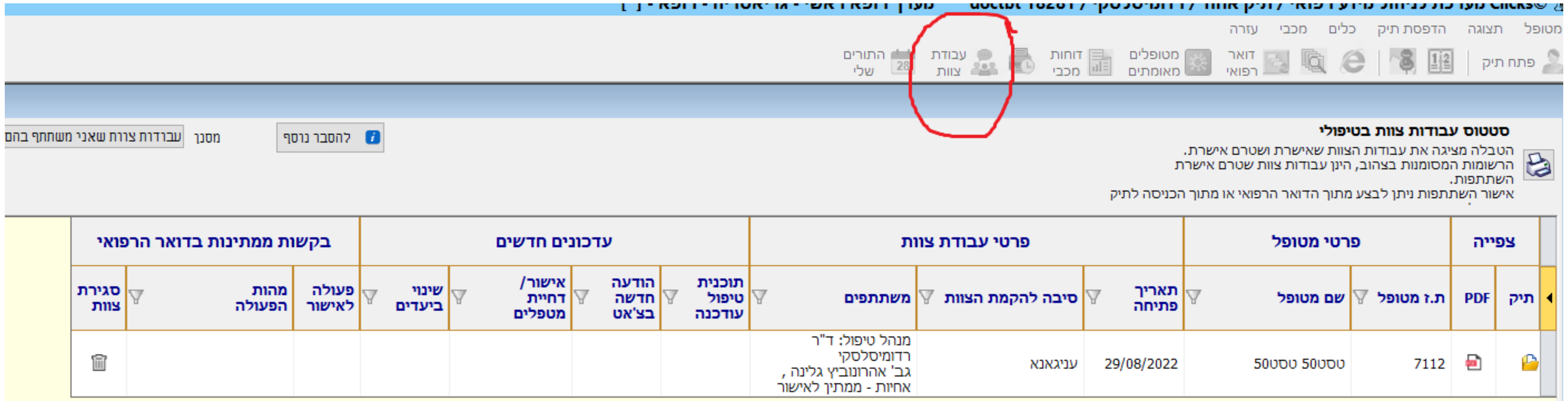
חבר מעל גיל 65 המקבל סיוע במסגרת חוק

המטופל אותר ע"י המערכת כ"חולה מורכב"

# יצירת צוות אינטגרטיבי סביב מטופל




מביאים את רפואת העתיד. מהר!

# שאלונים לקראת ביקור אצל גריאטר - עצימת המטופל ודיווח עצמי

| חודש ושנה | סך הורדות |
|---|---|
| ינו-21 | 64 |
| פבר-21 | 91 |
| מרץ-21 | 80 |
| אפר-21 | 87 |
| מאי-21 | 72 |
| יונ-21 | 114 |
| יול-21 | 80 |
| אוג-21 | 91 |
| ספט-21 | 75 |
| אוק-21 | 85 |
| נוב-21 | 111 |
| דצמ-21 | 78 |
| ינו-22 | 85 |
| פבר-22 | 48 |
| מרץ-22 | 36 |
| אפר-22 | 44 |
| מאי-22 | 86 |
| יונ-22 | 105 |
| יול-22 | 67 |
| אוג-22 | 48 |
| ספט-22 | 50 |
| אוק-22 | 65 |
| סה"כ | 1,662 |

# עוד כלים

**קמפיינים ו אוטומציה** :

- פעילות גופנית,
- מניעת הדרדרות קוגניטיבית
- מניעת נפילות
- התנהגות מזג אוויר קר, חם

**יומי בריאות:** סכרת, איתור רטינופטיה

**ניידות נוספות**: ממוגפיה

**קידום בריאות:** הרצאות, פליירים, קבוצות פעילות גופנית

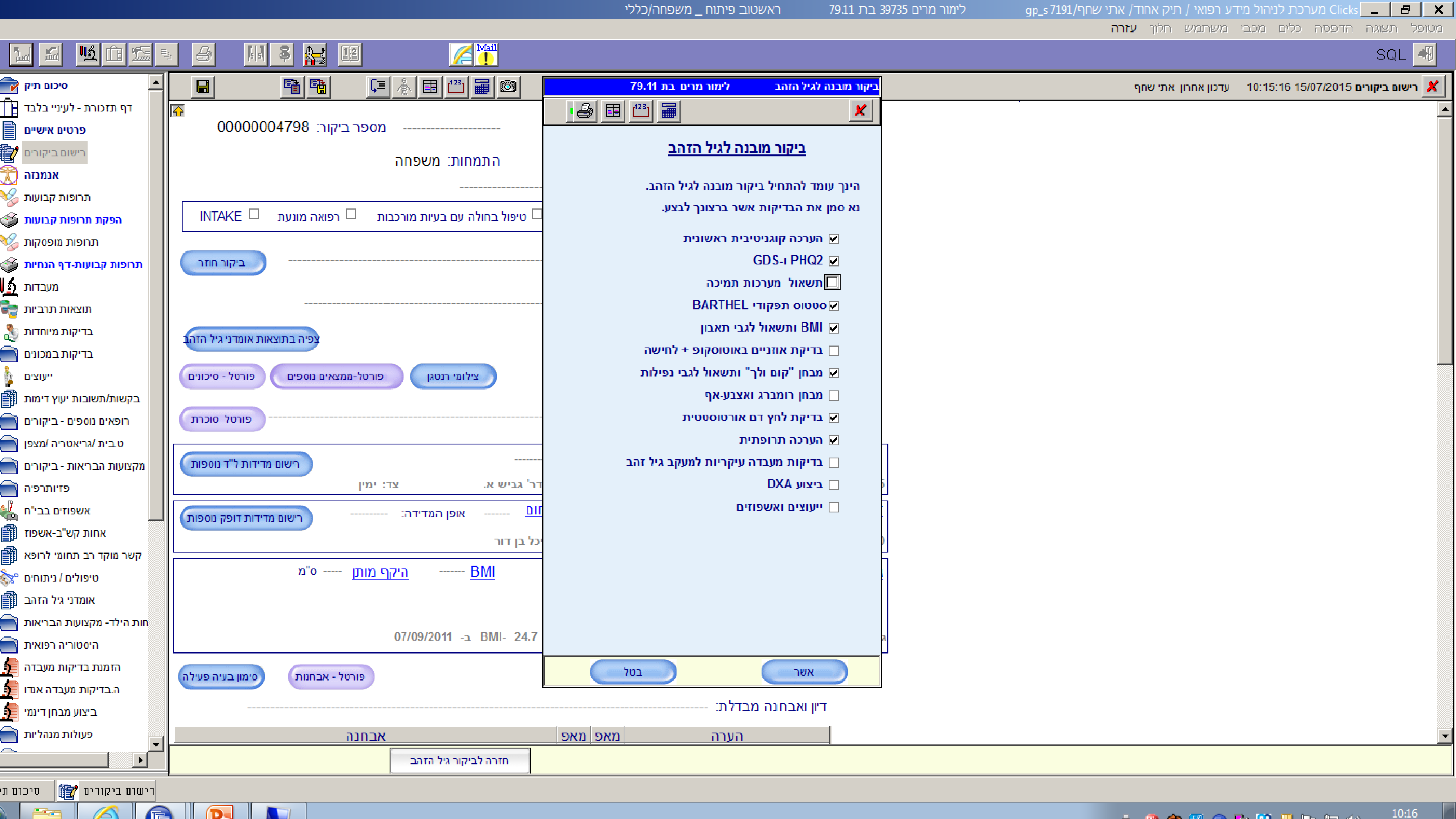
**מערכות תמיכה:**

- קבוצות תמיכה ,
- תכנית נפגשים ( מתנדבים של מכבי),
- שיתופי פעולה עם ראשויות "מרשם חברתי" ( עיריית ירושלים ותל אביב

ביקור
גיל הזהב
מכבי
שירותי הבריאות הטובים בישראל

# לומדה / תיק רפואי

| | |
|---|---|
| לומדה<br>BIKURZAHAV75 | SMART SET |


Clicks מערכת לניהול מידע רפואי / תיק אחוד / אתי שחף / gp_s 7191
לימור מרים 39735 בת 79.11
ראשטוב פיתוח _ משפחה/כללי
מטופל תצוגה הדפסה כלים מכבי משתמש חלון עזרה
SQL
רישום ביקורים 15/07/2015 10:15:16 עדכון אחרון אתי שחף
סיכום תיק
דף תזכורות - לעיני בלבד
פרטים אישיים
רישום ביקורים
אנמנזה
תרופות קבועות
הפקת תרופות קבועות
תרופות מופסקות
תרופות קבועות-דף הנחיות
מעבדות
תוצאות תרביות
בדיקות מיוחדות
בדיקות במכונים
יועצים
בקשות/תשובות יעוץ דימות
רופאים נוספים - ביקורים
ט.בית /גריאטריה /מצפן
מקצועות הבריאות - ביקורים
פיזיותרפיה
אשפוזים בבי"ח
אחות קש"ב-אשפוז
קשר מוקד רב תחומי לרופא
טיפולים / ניתוחים
אומדני גיל הזהב
חות הילד- מקצועות הבריאות
היסטוריה רפואית
הזמנת בדיקות מעבדה
ה.בדיקות מעבדה אדו
ביצוע מבחן דינמי
פעולות מנהליות
מספר ביקור: 00000004798
התמחות: משפחה
INTAKE
רפואה מונעת
טיפול בחולה עם בעיות מורכבות
ביקור חוזר
צפיה בתוצאות אומדני גיל הזהב
פורטל - סיכונים
פורטל-ממצאים נוספים
צילומי רנטגן
פורטל סוכרת
רישום מדידות ל"ד נוספות
צד: ימין
דר' גביש א.
רישום מדידות דופק נוספות
אופן המדידה:
BMI
היקף מותן
ס"מ
07/09/2011 ב- BMI- 24.7
סימון בעיה פעילה
פורטל - אבחנות
דיון ואבחנה מבדלת:
אבחנה
מאפ
מאפ
הערה
חזרה לביקור גיל הזהב
ביקור מובנה לגיל הזהב
לימור מרים בת 79.11
ביקור מובנה לגיל הזהב
הינך עומד להתחיל ביקור מובנה לגיל הזהב.
נא סמן את הבדיקות אשר ברצונך לבצע.
☑ הערכה קוגניטיבית ראשונית
☑ PHQ2 ו-GDS
☐ תשאול מערכות תמיכה
☑ סטטוס תפקודי BARTHEL
☑ BMI ותשאול לגבי תאבון
☐ בדיקת אוזניים באוטוסקופ + לחישה
☑ מבחן "קום ולך" ותשאול לגבי נפילות
☐ מבחן רומברג ואצבע-אף
☑ בדיקת לחץ דם אורטוסטטית
☑ הערכה תרופתית
☐ בדיקות מעבדה עיקריות למעקב גיל זהב
☐ ביצוע DXA
☐ ייעוצים ואשפוזים
אשר
בטל
רישום ביקורים
סיכום תי
10:16

*Family Medicine and Community Health Journal*

*2024 הגשה*

**Number of patients who received the following diagnoses for the first time ever in the three months following the index date.**

| | Golden visit 1421N= | | No golden visit N=2446 | |
|---|---|---|---|---|
| | n | % | n | % |
| Dementia/alzheimer | 37 | 2.60 | 20 | 0.82 |
| Depression | 53 | 3.73 | 13 | 0.53 |
| Falling | 42 | 2.96 | 32 | 1.31 |
| Functional deterioration | 409 | 28.78 | 28 | 1.14 |
| Hearing loss | 14 | 0.99 | 9 | 0.37 |
| Mild cognitive impairment | 483 | 33.99 | 20 | 0.82 |
| Polypharmacy | 43 | 3.03 | 13 | 0.53 |
| Walking difficulty | 38 | 2.67 | 32 | 1.31 |
| Orthostatic hypotension | 11 | 0.77 | 3 | 0.12 |
| Cerumen impaction | 6 | 0.42 | 4 | 0.16 |
| Weight loss of 10% | 6 | 0.42 | 6 | 0.25 |

# גריאטריה יזומה

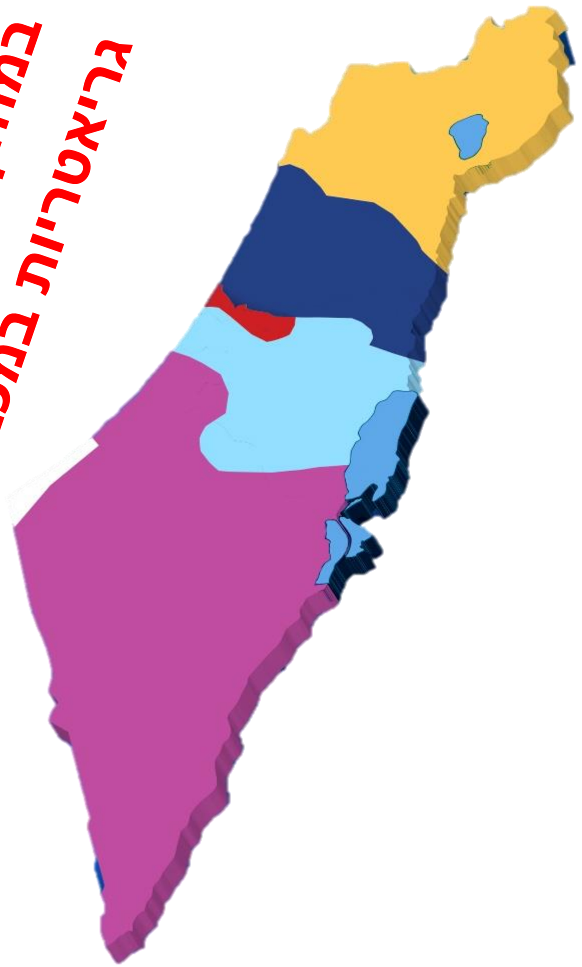
# איתור תסמינים גריאטריים:

| כמות מבקרים בניידת | מטופלים שקיבלו אבחנה חדשה | סה"כ אבחנות חדשות |
|---|---|---|
| 3500 | 1400 ביום הביקור | 2400 |

**40%** נבדקים קיבלו אבחנה חדשה ביום הביקור
האבחנות נבחנו מ 3 תחומים עיקריים:
**נפילות, דמנציה ודיכאון**

# פריסת שירות גריאטרי מכבי

במהלך 5 שנים האחרונות מספר מרפאות
גריאטריות במכבי גדל מ 18 ל 56 מרפאות



13 מרפאות רב תחומיות
43 מרפאות מייעצות

**מחוז צפון**

17% -432,065
מעל 65 – 59,800 –**13,8%**
רב תחומי-1 + ניידת
מרפאה מייעצת - 12

**מחוז שרון**

21% -527,454
מעל גיל 65 –-65,721- **12,4%**
רב תחומי- 4
מרפאה מייעץ - 6

**מחוז מרכז**

22% -549,756
מעל גיל 65 – 65,257 – **11,9%**
רב תחומי -1
מרפאה מייעצת – 14

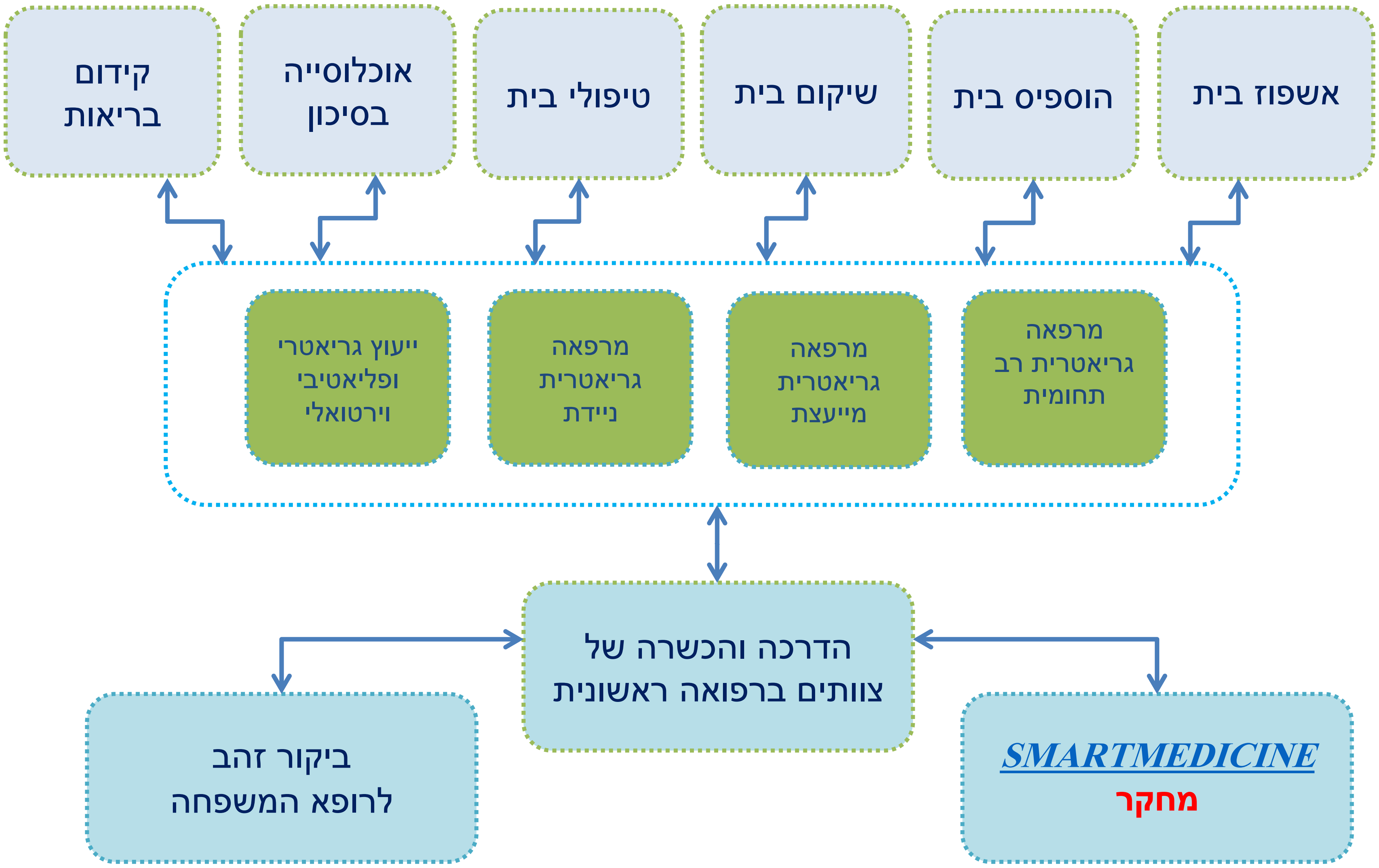
**מחוז י-ם שפלה**

25% - 632,041
מעל גיל 65 – 76,223 – **12,1%**
רב תחומי – 4
מרפאה מייעצת -5

**מחוז דרום**

15% -370,882
מעל גיל 65 – 44,845 – **12,1%**
מרפאות רב תחומיות – 3
מרפאה מייעצת – 6

# שירות גריאטרי במכבי

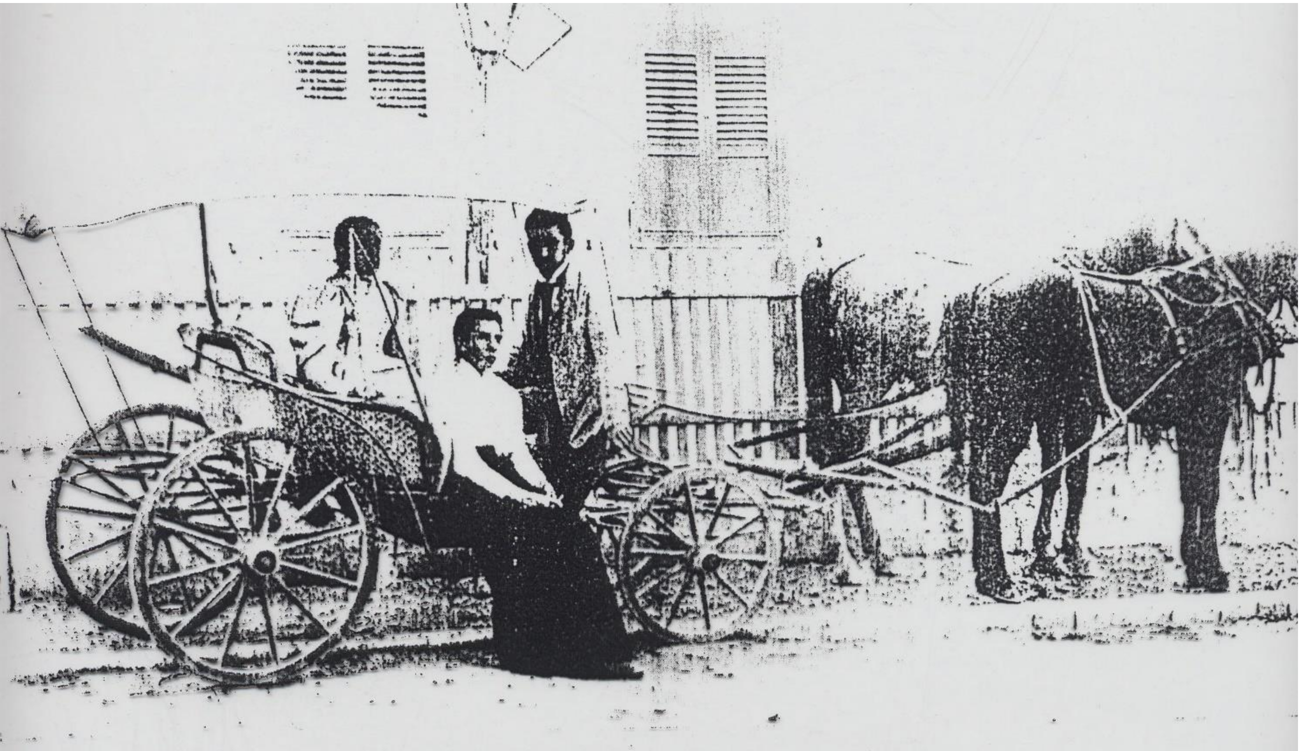


# ביקורי בית

- עידוד הגריאטריים לביצוע ביקורי בית ע"י מודל תגמול ייעודי

ביקור בית לצורך <u>עבור מטופלי היחידה לטיפולי בית</u> וזכאיים לחוק סיעוד 5,6 שלא בשעות עבודה, **באישור גריאטר המחוזי**

- **"הערכה גריאטרית כוללנית"**
- **ייעוץ גריאטרי**



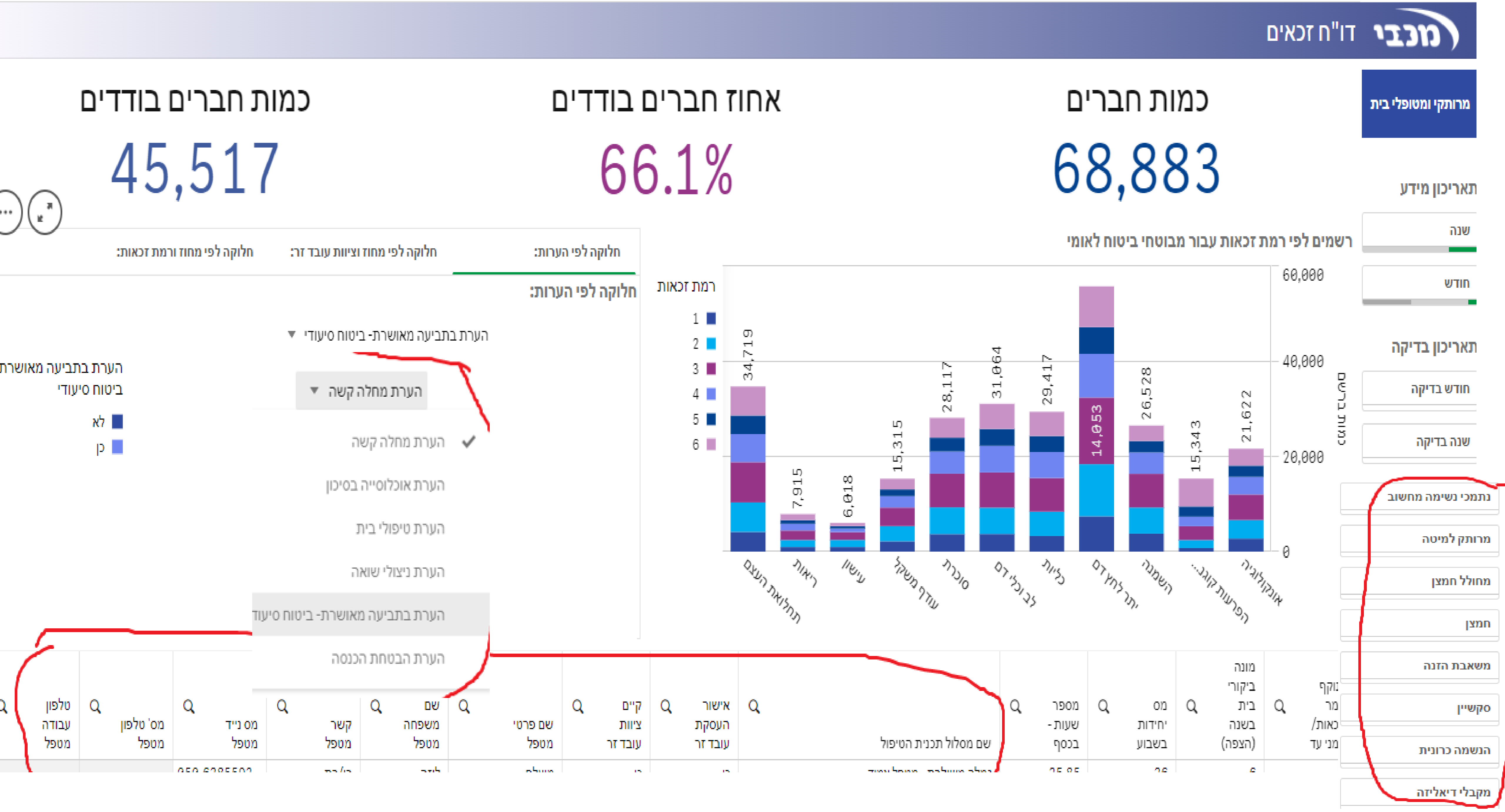
ד"ר יפה אחותו רוזה ואמו, בזכרון־יעקב בשנת 1894

**ביחידה לטיפולי בית כ- 6.500 מטופלים. מטופלים על ידי צוות רב תחומי.**

**קליטה, הדרכה, בקרה, טכנולוגיות, ועדת אישור מתן תרופות בבית**

**כ-800 מטופלים מאושפזים בהוספיס בית**

**קליטה, הדרכה, בקרה**



מכבי
דו"ח זכאים
מרותקי ומטופלי בית
כמות חברים
68,883
אחוז חברים בודדים
66.1%
כמות חברים בודדים
45,517
תאריכון מידע
שנה
חודש
תאריכון בדיקה
חודש בדיקה
שנה בדיקה
נתמכי נשימה מחשוב
מרותק למיטה
מחולל חמצן
חמצן
משאבת הזנה
קשיין
הנשמה כרונית
מקבלי דיאליזה
רשומים לפי רמת זכאות עבור מבוטחי ביטוח לאומי
רמת זכאות
1
2
3
4
5
6
60,000
40,000
20,000
0
34,719
7,915
6,018
15,315
28,117
31,064
29,417
14,053
26,528
15,343
21,622
תחלואת העצם
ריאות
עישון
עודף משקל
סוכרת
לב וכלי דם
כליות
יתר לחץ דם
השמנה
הפרעות קוגנ...
אונקולוגיה
חלוקה לפי הערות:
חלוקה לפי מחוז וציוות עובד זר:
חלוקה לפי מחוז ורמת זכאות:
חלוקה לפי הערות:
הערת בתביעה מאושרת- ביטוח סיעודי
הערת מחלה קשה
הערת מחלה קשה
הערת אוכלוסייה בסיכון
הערת טיפולי בית
הערת ניצולי שואה
הערת בתביעה מאושרת- ביטוח סיעודי
הערת הבטחת הכנסה
הערת בתביעה מאושרת
ביטוח סיעודי
לא
כן
מונה ביקורי בית בשנה (הצפה)
סם יחידות בשבוע
מספר שעות - בכסף
שם מסלול תכנית הטיפול
אישור העסקת עובד זר
קיים ציוות עובד זר
שם פרטי מטפל
שם משפחה מטפל
קשר מטפל
מס נייד מטפל
מס' טלפון מטפל
טלפון עבודה מטפל

מומחית קלינית בסיעוד גריאטרי

**משרד הבריאות**

# חוזר חטיבת הרפואה

חוזר מס' : 4/2021

ירושלים, כ"ד תמוז, תשפ"א
4 יולי, 2021

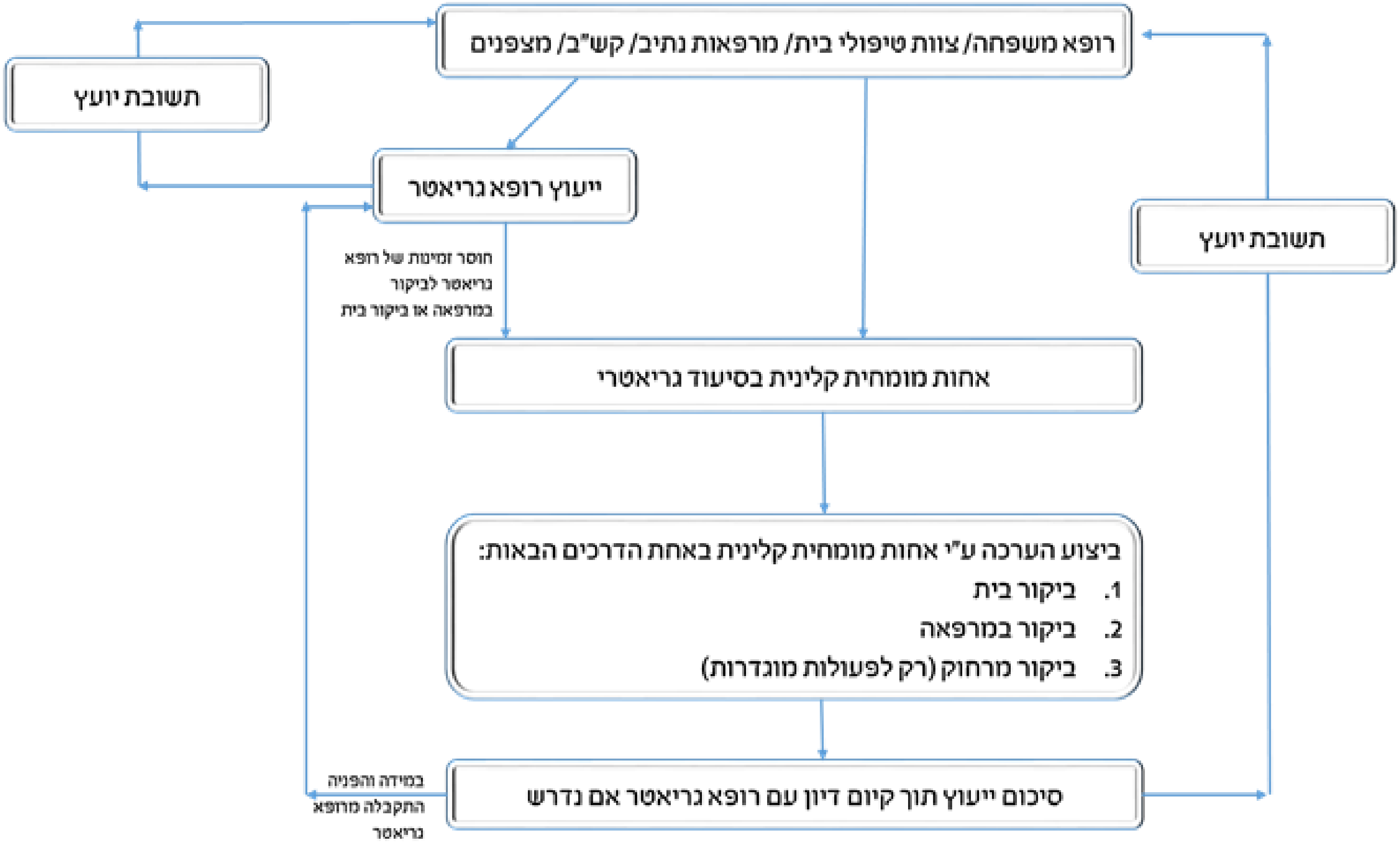
אל: מנהלי בתי החולים
מנהלי האגפים הרפואיים – קופות החולים

הנדון: נהלי עבודת אחות מומחית לסיעוד גריאטרי בקהילה

סימוכין: חוזר המנהל הכללי מס' 9/2014 - "אחות מומחית"
חוזר חטיבת הרפואה מס': 25/2014 -"נהלי עבודה לאחות מומחית בסיעוד גריאטרי במערך האשפוז הגריאטרי"
חוזר מינהל רפואה מס' 12/2007 - "אמות מידה למרפאות להערכה גריאטרית כוללנית בקהילה"
חוזר חטיבת הרפואה מס' 8/2020 - "נהלי עבודת אחות מומחית לסיעוד גריאטרי במערך האשפוז הכללי"

בהמשך לחוזרים שבסימוכין הננו להביא בזאת לידיעתכם הנחיות בנושא שבנדון.

# אחות מומחית בסיעוד גריאטרי ופליאטיבי



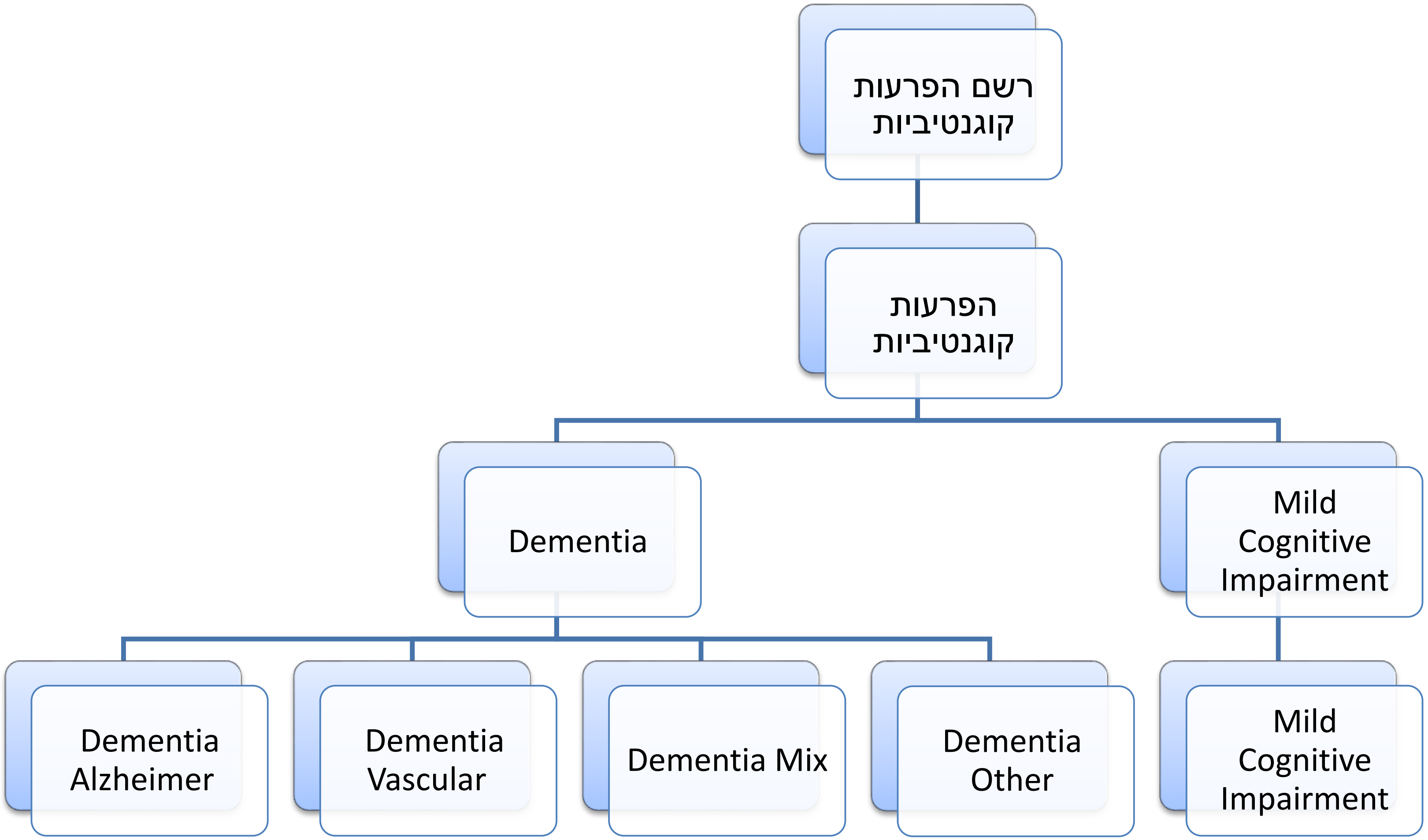

מביאים את רפואת העתיד. מהר!
חטיבת הבריאות

# שותפים בקהילה

**יחידת סגולה** מוקד זכויות לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם
ביוזמת המשרד לשוויון חברתי

**מרכזי אפ 60+ הכוונה וצמיחה לאזרחים ותיקים**
סיוע בהיערכות ובתכנון תהליך ההזדקנות ובעיקר ניהול ותכנון של תקופת הפרישה.

# רשם הפרעות קוגניטיביות – עץ המחלות



# פעילות מכוונת לאוכלוסיות ברשם דמנציה

**למטופלים עם ירידה קוגניטיבית קלה נשלחות קמפיינים תקופתיים.**

## ירידה קוגניטיבית קלה

חזרה למגזין

תאריך: 25.11.2019

### איך תוכלו להאט בעצמכם את התהליך

ייעוץ רפואי: ד"ר זוריאן רדומיסלסקי, גריאטר ארצי, מכבי

**ירידה קוגניטיבית קלה (Mild Cognitive Impairment - MCI) היא מצב שבו מופיעים שינויים בזיכרון ובתפקודי החשיבה, אך הם אינם משפיעים על התפקוד היום יומי. אנשים שחווים ירידה קוגניטיבית קלה חיים באופן עצמאי בקהילה, מודעים למצבם, ויש להם יכולת ללמידה חדשה ולתרגול יכולות החשיבה שלהם.**

**שימור הכושר הקוגניטיבי**
סדנה הכוללת מפגשים קבוצתיים ועבודה עצמאית מול מחשב.

שכיחות התופעה מוערכת בכ-18% מכלל האוכלוסייה, והיא יכולה להתחיל בשנות ה-60 לחיים. אנחנו במכבי פועלים לשמר את המצב הקיים, למנוע הידרדרות נוספת ביכולות החשיבה, ואף לשפר את המצב.

**אורח חיים בריא הכולל פעילות גופנית, תזונה מאוזנת ופעילות חשיבתית יכול לסייע:**

### אורח חיים פעיל

**פעילות גופנית אירובית, חיזוק שרירים ושיפור שיווי המשקל**

פעילות גופנית בגיל השלישי עשויה לסייע במניעת הידרדרות בתפקודי החשיבה ובמניעת ירידה קוגניטיבית. על פי מחקרים, מי שהקפידו על פעילות גופנית בגיל השלישי הפחיתו ב-52% את הסיכון לירידה קוגניטיבית 21 שנים לאחר מכן, וזאת בהשוואה למבוגרים שלא עסקו בפעילות כלשהי.

ארגון הבריאות העולמי ממליץ על פעילות גופנית אירובית בשילוב עם פעילות לחיזוק השרירים ופעילות לשיפור שיווי המשקל. הפעילות האירובית צריכה להיות ברמת עצימות בינונית, כגון הליכה ושחייה, במשך 150 דקות בשבוע, ביחידות זמן של לפחות 10 דקות ברצף; פעילות גופנית לחיזוק שרירים כללי צריכה להתבצע לפחות פעמיים בשבוע למשך כ-20 דקות בכל פעם; ופעילות לשיפור שיווי המשקל צריכה גם היא להתבצע לפחות פעמיים בשבוע. אם אינכם סובלים מבעיה רפואית המונעת מכם להתעמל, מומלץ להצטרף לקבוצות התעמלות במסגרת הקהילה.

אנשים שאינם פעילים, ומעוניינים להתחיל בכך, צריכים להתחיל להתעמל באופן מתון ובפרקי זמן קצרים, ובהדרגה להעלות את עוצמת התרגול, תדירותו ומשך הזמן.

סדנאות לפעילות גופנית ולשיווי משקל לבני 65+ במכבי >

### תזונה למניעת הידרדרות קוגניטיבית

שלום אלינה,
האם הבחנת לאחרונה בשינוי כלשהו ביכולת הזיכרון או החשיבה? גם אם לא – חשוב להכיר את התופעה.
לרשימת המלצות לשיפור היכולות לחצו: https://Macb.li/2232?d=30554255
בברכה , מכבי שירותי בריאות

אם אינך רואה מייל זה לחצי כאן

# מטופל דמנציה

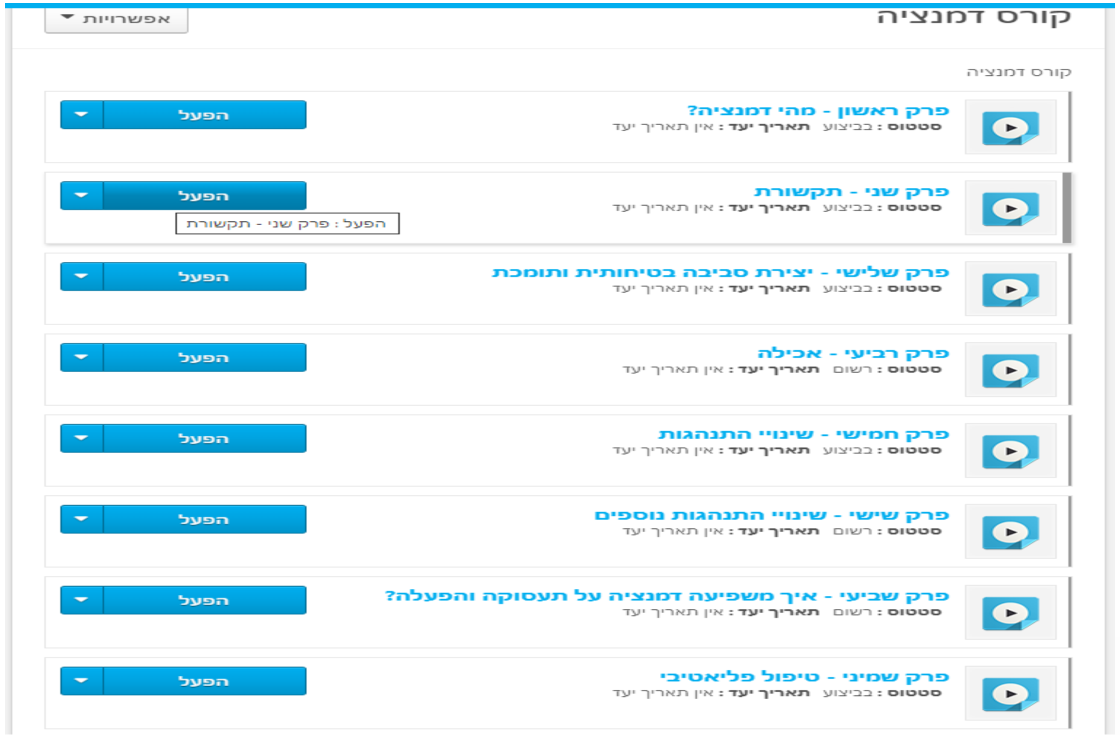
א. הכנסה לסל מכבי סרוקוול בהתוויה דמנציה עם הפרעות התנהגות

ב. תכנית בשיתוף עם עמדא:

מטופלי דמנציה מקבלים קוד בשם "התייחסות מיוחדת".

עובדי מנהל ( משריות ומזכירות) עברות לומדה איך להתייחס למטופל עם ירידה קוגניטיבית

מטרה – לעלות רמת שירות למטופלים אלו בכל שטח המרפאות/סניפים במכבי.



## מטופל דמנציה  פעילות למטפלים

[חוברת הדרכה למטופלי בית ולמטפל העיקרי | מכבי שירותי בריאות ((maccabi4u.co.il](maccabi4u.co.il)

# תמיכה במשפחות חוליי דמנציה

**סיכום קבוצות תמיכה ומידע לבני משפחה מטפלים לשנת2022:**

- ❑ 13 קבוצות תמיכה לבני משפחה מטפלים באנשים עם דמנציה
- ❑ 7 קבוצות מידע
- ❑ כ – 10 קבוצות מידע וקבוצות תמיכה ייעודיות לאוכלוסייה מתוכננות עד סוף השנה

ובנוסף:

- הרצאות בקהילה בנושא בריאות מנטלית בגיל השלישי
- יום "שיא" – בוקר מידע לבני משפחה מטפלים בבן משפחה עם ירידה קוגניטיבית  דוברי רוסית

מכבי
קבוצת הבריאות הטובה בישראל

# מטופלים עם דמנציה מתקדמת

**חולים  עם דמנציה בשלב מתקדם מאובחנים בשיטיון לפחות 3 שנים וצפי לתוחלת החיים כ חצי שנה**

ובמיוחד בליווי מחלות נוספות אשר הפסיקו לקבל טיפול ייעודי לדיכוי המחלה ואשר מקבלים טיפול תומך להקלה

על סימפטומים בלבד ואשר  בן משפחה המעוניין בגישת טיפול של הוספיס ונוכחות מטפל כל שעות היממה.

בהתאם לקריטריונים:

1. ירידה קוגניטיבית (בעיות זיהוי, התמצאות ותקשורת) לפחות שלושה חודשים. תקשורת מינימלית 6 מילים. 7c FAST
2. תלות בכל ה ADLs לפחות חצי שנה. לפי קרנופסקי או ברטל- רוב הזמן יממה מרותק למיטה/כיסא
3. בנוסף אחד מ:

- יותר משני אשפוזים בטווח של חצי שנה (מכל סיבה)
- אספירציות מתועדות לפחות פעמיים בחצי שנה
- UTI לפחות פעם אחת בחצי שנה אחרונה
- ירידה של יותר מ 10% במשקל בחצי שנה האחרונה
- הפרעות אכילה / בליעה
- סיכון מוגבר לפצעי לחץ או קיומם. ( אלבומין פחות מ 2.5 מ"ג/דל, נורטון נמוך מאוד, פחות מ10)

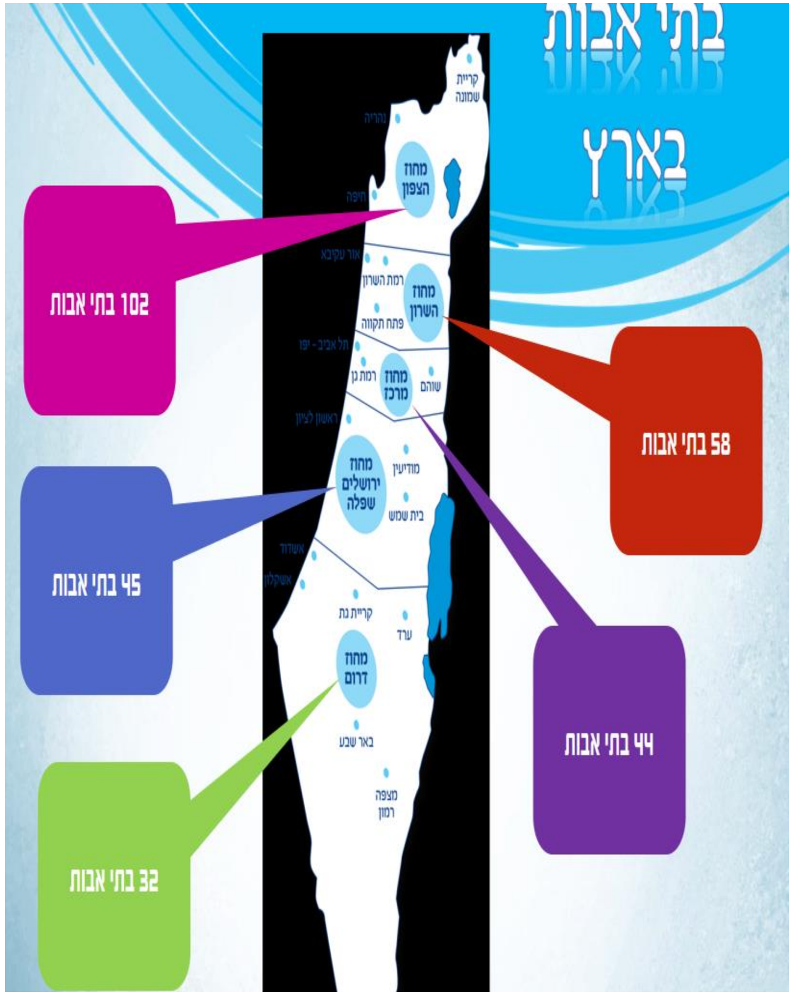
# קשר עם גורמים מטפלים במבוטחי מכבי - מרפאות " נתי"ב"

**רופא ראשי** I סיעוד ומקצועות הבריאות

**מרפאת נתי"ב**

אשפוז מוסדי בליווי קהילתי

## תהליכי עבודה ותפקיד של צוות המרפאה :




1. **זיהוי מטופלים מאושפזים במוסדות הגריאטרים דרך דוחות של מכביפארם ומשרד הבריאות.**
2. **העברת שיוך מאושפזים מרופא משפחה לרופא "נתיב"**

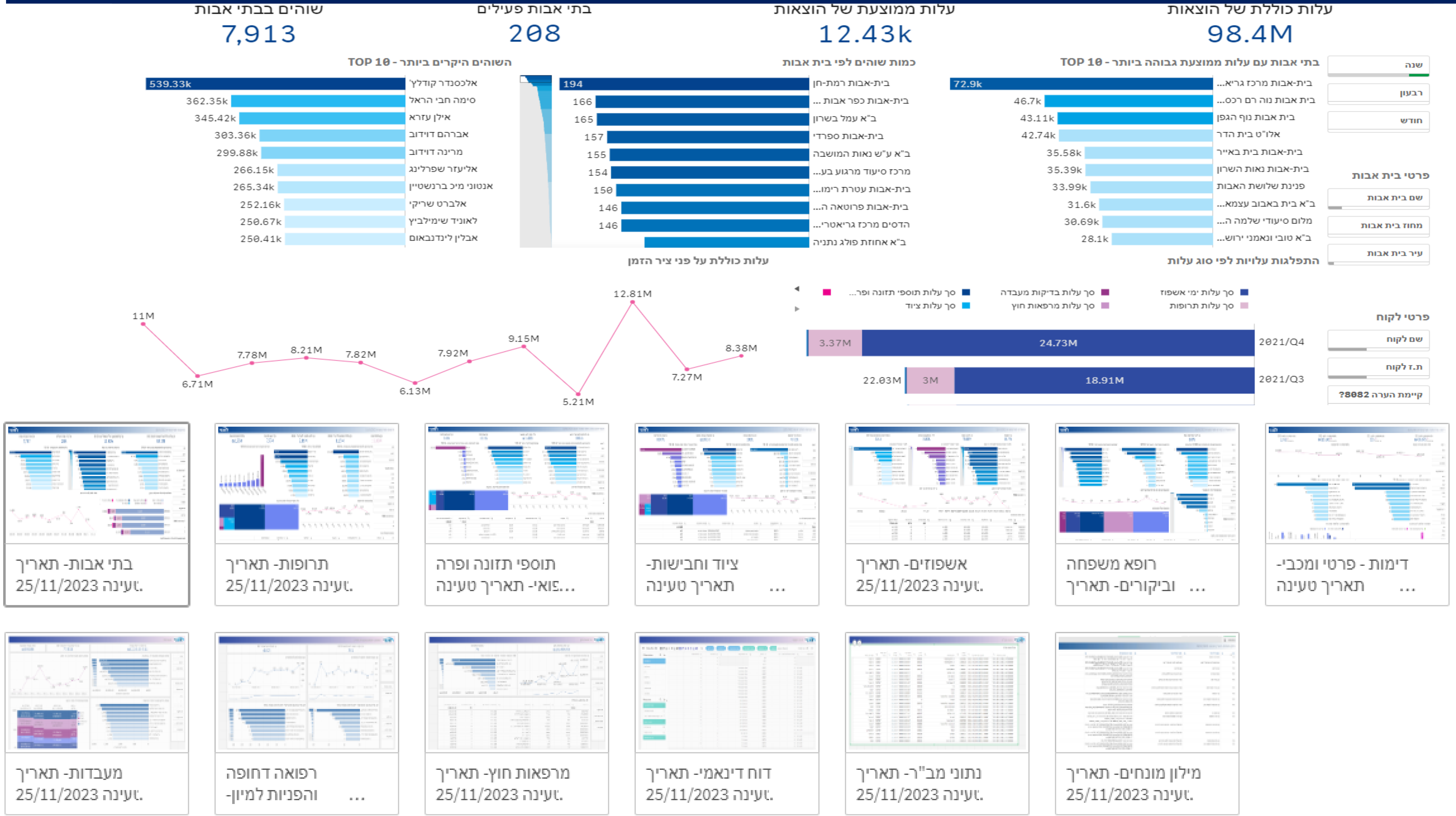
**תפקיד של צוות:**

- מעקב אחר האיכות הקלינית של הטיפול הניתן במוסד. על ידי ביקור אדמיניסטרטיבי ופרונטלי , במקרה הצורך
- ייעוצים וירטואלים בתחום רפואה שניונית למבוטחי מכבי בבתי אבות רוקח קליני
- מעקב ובקרה אחר מתן תרופות וטיוב הטיפול התרופתי.
- מעקב ובקרה אחר מתן מזון ייעודי, תחבושות מורכבות וציוד רפואי
- עזרה בתהליכים בירוקראטיים במתן אישור לתרופות, ט 17.
- הדרכה לצוותים בבתי האבות ומוסדות האשפוז.
- מתן טיפולי IV כחלופה לאשפוז יום במתקני מכבי.
- הדרכה בכל הנוגע טיפול בסטומה, פצעים וכו'.

מביאים את רפואת העתיד. מהר!

הטיבת הבריאות

# שליטה בנתונים



# תאום מערכות דיור מוגן

מכבי
שירותי בריאות

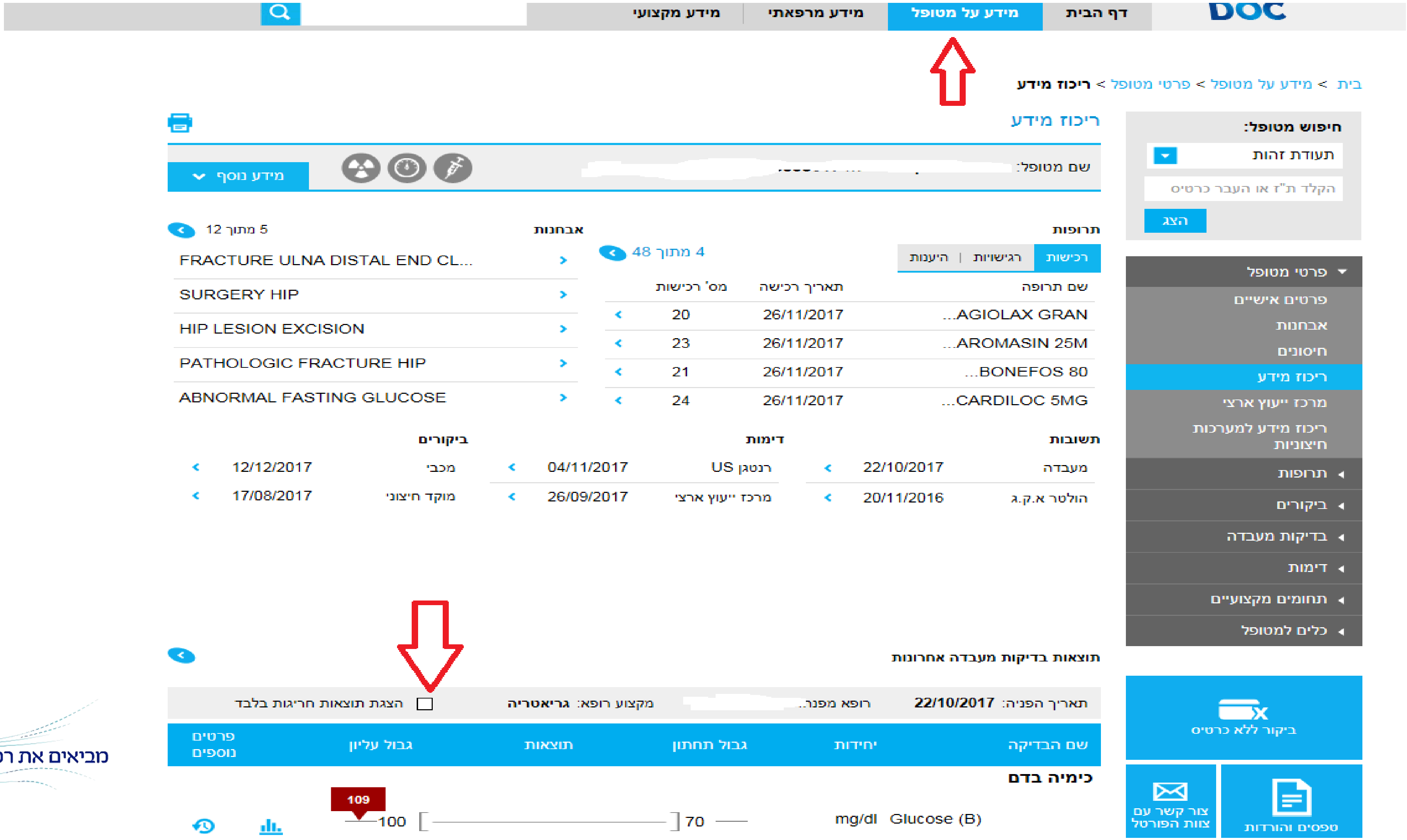
- כ-90 בתי דיור מוגן
- כ-15,000 דיירים
- מתוכם כ-3,000 חברי מכבי

רופא בבית הדיור יקבל גישה למידע במכבי

רופא מכבי יקבל לתוך התיק הרפואי את סיכום הביקור במרפאת בית הדיור

מביאים את רפואת העתיד. מהר!
הטיבת הבריאות

# רצף מידע עם מרפאות דיור מוגן ובתי אבות




מביאים את רפואת העתיד. מהר!
השיבת הבריאות

# תכנית מניעת נפילות מותאמת אישית- יש דרך להשפיע!

**איתור** : דיגיטלי 70-75+ רשם **OP**

בעזרת שאלון **STEADI**

**ריבוד** לפי דרגת סיכון לנפילה

סיכון נמוך, בינוני, גבוה

**השלמת בירור** לסיבות לנפילות

פוליפארמסי, בעיית ראיה/שמיעה, מבחן "קום ולך", הרגלי שינה, ל"ד אורתוסטטי, אי שליטה על סוגרים

**תכנית טיפול מותאמת** לדרגת סיכון

עבודת צוות, התאמת הבית, פיזיותרפיה קבוצתית/פרטנית, דיאטנית מר"ע, גריאטר, אנדוקרינולוג (**OP**), רוקח קליני

מביאים את רפואת העתיד. מהר!
חטיבת הבריאות

# שאלון דיגיטלי = אומדן נפילות בקליקס

**תיעוד אוטומטי בקליקס**

| | | |
|---|---|---|
| .I | **האם נפלת בשנה האחרונה?** | כן (1)<br>לא (0) |
| **א.** | כמה פעמים? | נפילה אחת (1)<br>2 נפילות (4)<br>יותר משתי נפילות (5) |
| **ב.** | האם היו חבלות / פציעות? | כן (4)<br>לא (0) |
| **ג.** | האם קמת לבד? | כן (0)<br>לא (1) |
| **ד.** | האם נזקקת לטיפול רפואי כתוצאה מחבלה/פציעה (מיון/אשפוז)? | כן (1)<br>לא (0) |
| .2 | האם אתה מרגיש לא יציב בזמן הליכה/עמידה | כן (1)<br>לא (0) |
| .3 | האם אתה מרגיש פחד מנפילה? | כן (1)<br>לא (0) |

| | |
|---|---|
| **ציון = 0** | **רמת סיכון נמוכה** |
| **1 <= ציון <= 5** | רמת סיכון בינונית |
| **ציון =< 6** | רמת סיכון גבוהה |

מכבי
קבוצת הבריאות הטובה בישראל
מביאים את רפואת העתיד. מהר!

# תרשים זרימה למופל

רמת סיכון נמוכה לנפילות

דף מידע על נפילות למטופל

https://www.maccabi4u.co.il/29922-he/maccabi.aspx

רמת סיכון בינונית לנפילות

רשם יל"ד **וגם** פוליפארמסי

YES

הפנייה לאחות

דף מידע על נפילות למטופל

https://www.maccabi4u.co.il/29922-he/maccabi.aspx

NO

הפניה לפיזיו

רמת סיכון גבוה לנפילות

שליחת זימון תור לרופא משפחה

דף מידע על נפילות למטופל

https://www.maccabi4u.co.il/29922-he/maccabi.aspx

לשלב בתוך התרשים של בכל רמות הסיכון

מכבי
קבוצת הבריאות הטובה בישראל

מביאים את רפואת העתיד. מהר!

# רשם נפילות – חדש ראשון בעולם!

**תיקוף מצבים קליניים לקורלציה לנפילה**
**על פי דוחות נפילות/שברים מ2017 עד 2020**

**כ 40 מצבים קליניים מצבים לדוגמא:**

- OBESITY
- JOINT
- ARRHYTHMIA
- AS
- DRUGS

**מצבים בעליי סיכון 3X :**

- תרופות שינה
- יותר מ2 תרופות לHTN
- חוק סיעוד עד רמה רביעית

| מסלולי כניסה לרשם | רמת סיכון |
|---|---|
| **מסלול קליני** | |
| CLINICAL_CRITERIA_SCORE_1 - _5 | סיכון נמוך |
| CLINICAL_CRITERIA_SCORE_^_5 | סיכון בינוני |
| **מסלול אבחנות נפילה / שבר** | |
| FRACTURE_DIAGNOSES_OSTEOPOROSIS_REGISTRY | סיכון גבוה |
| FALL_DIAGNOSES | סיכון גבוה |
| **מסלול תשאול דיגיטלי/פרונטלי** | |
| PHYSIO_FALL_QUESTIONING_ONE_FALL | סיכון גבוה |
| FALL_ESTIMATION_LOW | סיכון נמוך |
| FALL_ESTIMATION_MED | סיכון בינוני |
| FALL_ESTIMATION_HIGH | סיכון גבוה |

# קידום בריאות - מניעת חולי וגורמי סיכון

בדיקת דם

היעדר שליטה

יתר לחץ דם

צפיפות העצם

ריבוי תרופות

שמיעה

חיסון שפעת, הרפס זוסטר, ופנאומווקס

תזונה

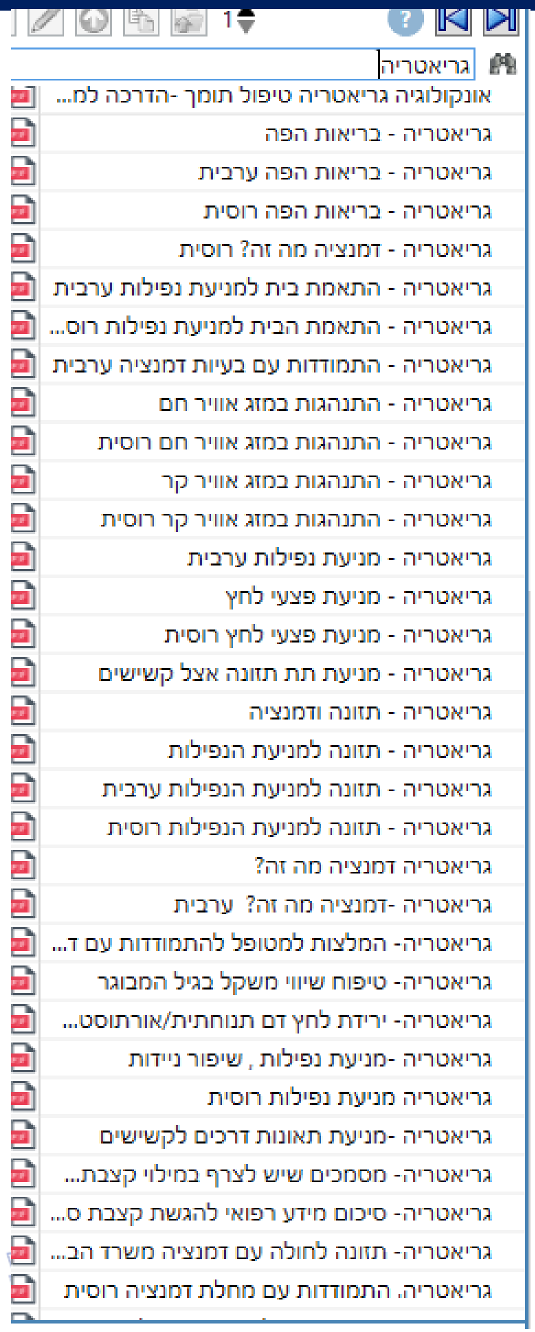
פעילות גופנית

מביאים את רפואת העתיד. מהר!
חטיבת הבריאות

# הכשרות

- יומי עיון ארצי ומחוזי
- כנסים ארציים ומחוזיים
- בתי ספר לגריאטריה במחוזות
- הרצאות ביומי עיון של תחומים אחרים
- לומדות: דמנציה, חולה נוטה למות, ביקור גיל הזהב , נפילות.
- הכשרות עובדים זרים בשפות רוסית ואנגלית
- תמיכה בלימודי המשך חוץ למכבי
- דפי מידע למטופלים בתיק רפואי בתחום זקנה
- <u>אוטומציה חודשית  של שליחת מאמרים מ NEJM קשורים לזקנה.</u>
- השתתפות במחקר

# דפי מידע


גריאטריה
אונקולוגיה גריאטריה טיפול תומך -הדרכה למ...
גריאטריה - בריאות הפה
גריאטריה - בריאות הפה ערבית
גריאטריה - בריאות הפה רוסית
גריאטריה - דמנציה מה זה? רוסית
גריאטריה - התאמת בית למניעת נפילות ערבית
גריאטריה - התאמת הבית למניעת נפילות רוס...
גריאטריה - התמודדות עם בעיות דמנציה ערבית
גריאטריה - התנהגות במזג אוויר חם
גריאטריה - התנהגות במזג אוויר חם רוסית
גריאטריה - התנהגות במזג אוויר קר
גריאטריה - התנהגות במזג אוויר קר רוסית
גריאטריה - מניעת נפילות ערבית
גריאטריה - מניעת פצעי לחץ
גריאטריה - מניעת פצעי לחץ רוסית
גריאטריה - מניעת תת תזונה אצל קשישים
גריאטריה - תזונה ודמנציה
גריאטריה - תזונה למניעת הנפילות
גריאטריה - תזונה למניעת הנפילות ערבית
גריאטריה - תזונה למניעת הנפילות רוסית
גריאטריה דמנציה מה זה?
גריאטריה -דמנציה מה זה? ערבית
גריאטריה- המלצות למטופל להתמודדות עם ד...
גריאטריה- טיפוח שיווי משקל בגיל המבוגר
גריאטריה- ירידת לחץ דם תנוחתית/אורתוסט...
גריאטריה -מניעת נפילות , שיפור ניידות
גריאטריה מניעת נפילות רוסית
גריאטריה -מניעת תאונות דרכים לקשישים
גריאטריה- מסמכים שיש לצרף במילוי קצבת...
גריאטריה- סיכום מידע רפואי להגשת קצבת ס...
גריאטריה- תזונה לחולה עם דמנציה משרד הב...
גריאטריה. התמודדות עם מחלת דמנציה רוסית

דמנציה
ואלצהיימר.
מה זה?
מבוסס על חוברת
הדרכה למטפל, ארגון
אלצהיימר בקנדה
מכבי
שירותי הבריאות הטובים בישראל
יש קופות חולים ויש מכבי *3555

דמנציה
ואלצהיימר
המלצות להתמודדות
עם מחלה למטופל
ולקרובי משפחה
מכבי
שירותי הבריאות הטובים בישראל
יש קופות חולים ויש מכבי *3555

דוגמאות:

1. Hochwald, I. H., Yakov, G., **Radomyslsky, Z.**, Danon, Y., & Nissanholtz-Gannot, R. (2021). Ethical challenges in end-stage dementia: Perspectives of professionals and family care-givers. *Nursing Ethics*, 0969733021999748
[Cited by: 0; ISI; IF: 2,874; 11/56; Q1 in ethics 17/122; Q1 in nursing]

2. Hochwald, I. H., Yakov, G., **Radomyslsky, Z.** & Nissanholtz-Gannot, R. (2021). Food for thought - ethical dilemmas and moral challenges in caring for people with end stage dementia in home care settings in the community. *Bio-Ethics Journal, Safed Center for Bioethics: Law, Ethics and Health Sciences*.(published in Hebrew)

3. Bentur, N., Cohen-Mansfield, J., & **Radomyslsky, Z.** (2021). Is Pain Assessment of Community-Dwelling Persons With Advanced Dementia by Family and Paid Care Workers Feasible?. *Journal of Pain and Symptom Management, 61*(5), 1028-1034.
Doi: https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.11.004
[Cited by: 0; ISI; IF: 3,612; 85/208; Q2 in CLINICAL NEUROLOGY 33/107; Q2 in HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES 47/167; Q2 in MEDICINE, GENERAL & INTERNAL]

תם הזמן

NEXT...

# עיריית ירושלים

ורד יוליוסבורגר, מנהלת הרווחה לגיל השלישי

# שירותים לאוכלוסיית הגיל השלישי

- אוריינות דיגיטלית
- דחיקת סיעוד
- התאלמנות בגיל מבוגר
- מרשם חברתי
- עיר ידידותית

## אוריינות דיגיטלית

**מטרת השירות** | הענקת כלים וידע בתחום האוריינות הדיגיטלית.

**משתתפים** | כ- 17,500 בני הגיל השלישי – על מגזרי.

**דרכי תקשורת** | קורסים פרונטליים, מפגשי זום ואירועים ברחבי העיר.

**תחומי אחריות** | הכרת המחשב, אפליקציות תחבורה, רשתות חברתיות, קניות ברשת, בריאות ומניעת הונאות.

בזכות מתקיני "**בטוח בבית**", **נחשפו והופנו** לתוכנית מאות מתושבי העיר.

**שלב א' הסתיים במרץ 2023, שלב ב' יחל אחרי החגים.**

אוריינות דיגיטלית

# הגעה לקהלי יעד

| | סה"כ | מתוכם **גיל שלישי** |
|---|---|---|
| **מגזר כללי** | 18,300 | 16,860 |
| **מגזר חרדי** | 5,300 | 470 |
| **מגזר ערבי** | 2,400 | 1,000 |

**26,000**

# התאלמנות בגיל מבוגר

**מטרת השירות**

מניעת הדרדרות מהירה (תוך שנתיים) של תושבים מעל גיל 65 שחוו התאלמנות.
מתן תמיכה פיזית ומנטאלית לאלמנות ולאלמנים בהתמודדות עם המשבר.

**משתתפים**

תושבים ותיקים בגיל 65-85, שהתאלמנו בשנה האחרונה.
מגזר כללי, ניידים, בעלי דרגת סיעוד נמוכה.

**מועד**

בין שלושה חודשים לשנתיים אחרי ההתאלמנות.

**השירות כולל**

הכוונה לשירותים קיימים ופיתוח מענים נוספים:
עיבוד אבל, כישורי חיים, עידוד יציאה לפעילות, תמיכה במשק הבית, פערים בירוקרטיים ומניעת נפילות.

**שיתוף פעולה** מקיף בין שירותים שונים בעיר **למען התושב.**
בין השותפים: **ביטוח לאומי, מינהלים קהילתיים ומרכזי מיצוי זכויות.**

יציאה לדרך באוקטובר 2023

# תכנית פעולה

**התאלמנות בגיל מבוגר**

## ביטוח לאומי

הפנייה לשיחת התאמה לקבוצה

שיחת התאמה

השתתפות בקבוצה

ביקור רכזת בקבוצה | תיאום שיחות אישיות | בניית קל"ע

## מענים עירוניים נוספים

שיחה פרטנית (20 דק') אינטק

**עירוני**

רישום לפעילות

**שכונתי**

- כן: ואוצ'ר/ שירות מסובסד
- לא: הצעת שכונה אחרת

## מיצוי זכויות

הפנייה לשירותי מיצוי זכויות לפי אזורים / שי"ל

שיחת מיצוי זכויות

---

SMS סיכום שיחה, לינק למיצוי זכויות ולאתר העירוני, קבוצת וואטסאפ

## דחיקת סיעוד

**מטרת השירות** מודל הוליסטי לדחיקת סיעוד בקרב תושבים קשישים, תוך שילוב מענים חברתיים, רפואיים וסביבתיים.

**משתתפים** מאות תושבים, מעל גיל 70, מקבלי גמלת סיעוד ברמה נמוכה (1-2), נדחי חוק סיעוד ובעלי מאפייני הדרדרות.

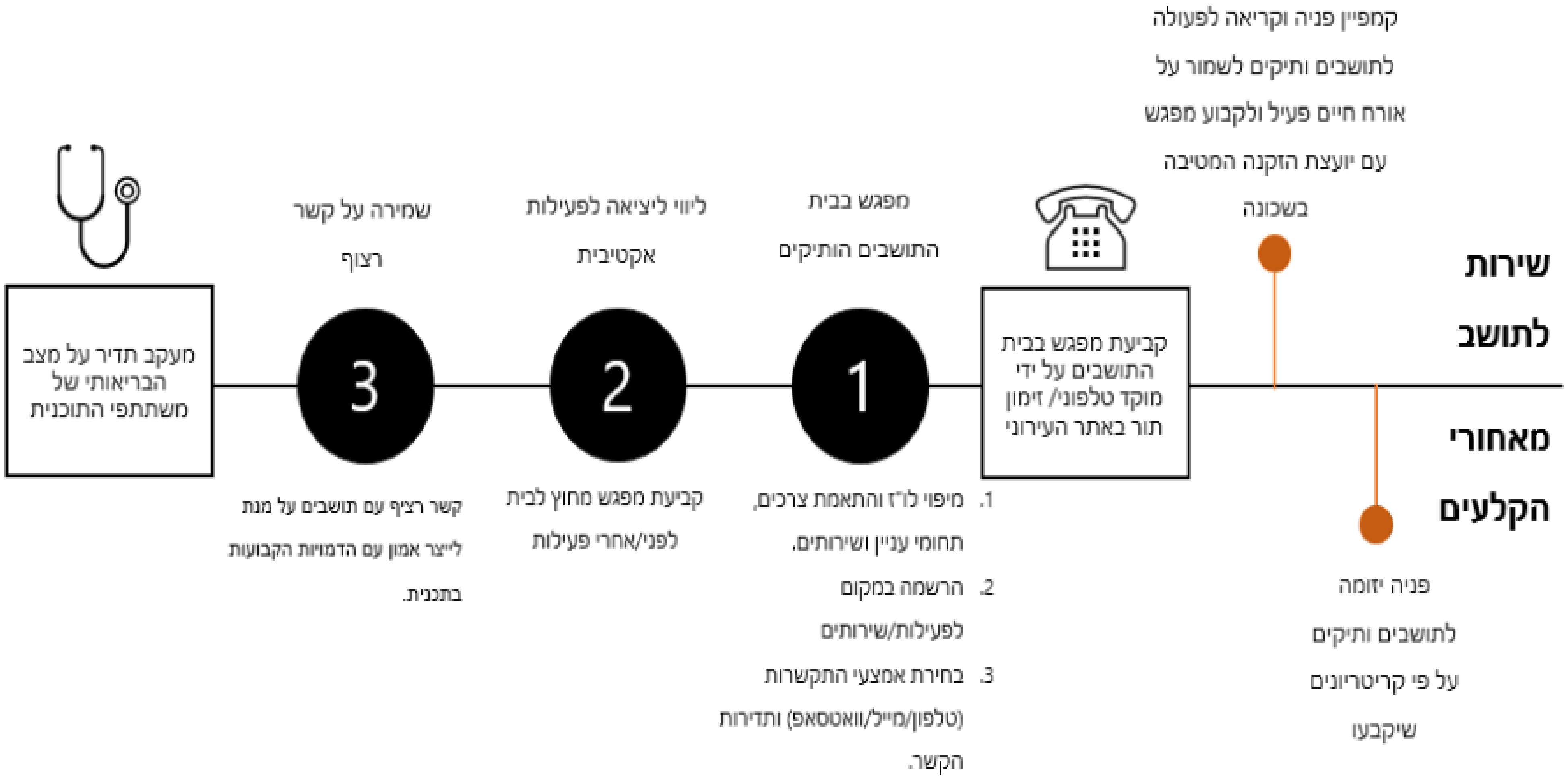
**השירות כולל**
רכיבי “pull” קבועים - מתן סבסוד לפעילות ספורטיבית, פעילות חברתית ולחצן מצוקה.
רכיבי "push" – מנהל לקוח, מאמן אישי מונחה ובדיקות גופניות למעקב.
רכיבי "Pull" לבחירה – קפה ועוגה, הופעות, קוסמטיקה, אוריינות דיגיטלית, התנדבות, התניידות, סל יועצים פרא-רפואיים, אפיקי הצלחה.

עיכוב ההתדרדרות, תשפר את **איכות חיי התושב ותחסוך כסף** רב לקופת המדינה.

**יציאה לדרך בתחילת 2024**

# תכנית פעולה

דחיקת סיעוד



# סל מענים למשתתפ/ת

מרכיבים מתחלפים לבחירה    מרכיבים קבועים בתכנית

# תם הזמן

# NEXT...

# עיריית תל אביב יפו

## פרח סומך, מנהלת תחום אזרחים ותיקים

# אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בעיר

בתל אביב יפו 73,023 תושבים מעל גיל 65

כ- 15,000 זכאי חוק ביטוח סיעוד.

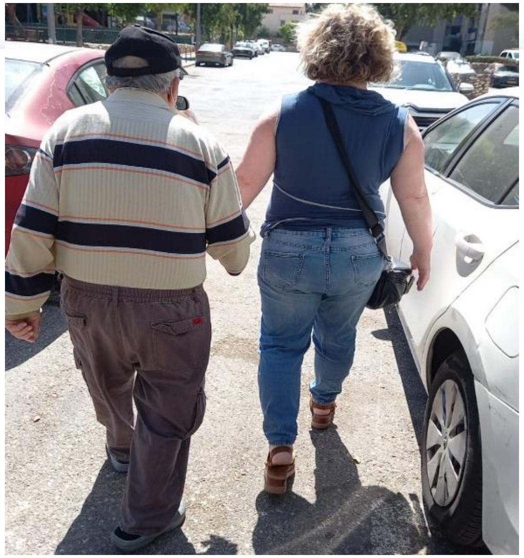
כ-3,300  זכאים ברמות 1-2

# השירותים והנכסים הארגוניים המרכזיים למניעת הדרדרות:

- שירותים אוניברסליים מפותחים.
- מקבלי שירות אוניברסלי במינהל השירותים החברתיים– **10,186**
- מקבלי שירות עם תיק – **9117**
- דיגתל- 52,000 מנויים מעל גיל 60
- "עיר ללא הפסקה"- תרבות, חברה, גיוון וריבוי.
- קידום חדשנות.

# עיר מקדמת הזדקנות מיטבית

- 100 תכניות שונות להפחתת בדידות כולל בסופי שבוע



- דיגיתל 60+
- ותיק בקליק
- להט"ב זהב

- עשרות פרלמנטים/פינות חמות
- 26 מועדונים חברתיים

אפ 60+

**רשות מקדמת הזדקנות מיטבית**
Muni 100

# עידן חדש – האג"ח החברתית המוניציפאלית הראשונה בישראל להפחתת בדידות

SOCIAL FINANCE ISRAEL

מטב

קרן תל־אביב
THE TEL AVIV FOUNDATION

תל אביב יפו TEL AVIV YAFO

# המהלכים, הפעולות והתכניות שמוביל הארגון למניעת הידרדרות

- נגישות חברתית- פעילויות ותהליכי עבודה ברשות מותאמים ומכלילים את האזרחים הוותיקים על שלל התפקודים.
- הליכתיות – כולל הליכתיות אזרחים ותיקים – muni 100
- נגישות למידע- דיגיתל + הסביבה שלי.

# פיילוט שכונת קריית שלום

**צוות עירוני בהשתתפות נציגי היחידות השונות הנפגש באופן קבוע אחת לשבועיים לדו"ח סטטוס:**

- **רשות התחבורה תנועה וחניה** – ניהול הפרויקט.
- **אגף התנועה** – תכנון תנועה, הרצאות הדרכות בסוגיות בטיחות בדרכים.
- **אדריכל העיר** – תכנון נופי במרחב ציבורי.
- **מינהל קהילה** – ניהול הממשק מול התושבים, איסוף מידע, שיתוף ציבור והכרת השכונה.
- **אגף שיפור פני העיר** – ביצוע ותחזוקה שוטפת של המרחב הציבורי.

# השתלבות ביוזמות ותוכניות עירוניות קיימות

תוכנית "הולכים על הליכתיות" עירונית כוללת.

יוזמה של מנהלת בית הספר היסודי בשכונה לתיעוד מכשולים במסגרת לימוד "השכונה שלי" בכיתות ד', ע"י התלמידים אחר הצהריים.

תוכנית עירונית לנטיעות להגברת צל ברחבי העיר ובשכונה.

מיפוי שבילים בשכונה כחלק מתוכנית עירונית.

רלב"ד
הרשות הלאומית

השתתפות במפגשי תושבים במסגרת תוכנית לבטיחות בדרכים לתושבים הוותיקים ואיסוף מידע באשר לשיפורים בנגישות הפיזית.

עיר ידידותית גיל

# "המרשם החברתי"- פיילוט מלווה מחקר

**השותפים:**

- **עיריית תל אביב יפו.**
- **דר' שני בכר אבניאלי- יזמת התכנית.**

# איתור של אוכלוסיית היעד על ידי קופ"ח מכבי

**מאפיינים מנבאים:**
**פרמטרים בריאותיים, תפקודיים, וסוציאליים.**

**הנחה שההתערבות המתוארת תמנע ירידה ותביא שיפור במדדים השונים.**

# Link worker

- ❖ מיפוי צרכים של האזרח הוותיק בפגישה-שימוש בשאלון מובנה.
- ❖ התאמת המענים המתאימים באזור מגוריו- חברתיים, סוציאליים, וקידום בריאות.
- ❖ הנגשת שירותים בקהילה, תוך דרבון וליווי לפעילויות השונות.
- ❖ הנגשה דיגיטלית ושימוש בדיגיתל.
- ❖ סיוע בגיוס מערכות תמיכה כגון משפחה, שכנים וקבוצת שווים (פרלמנט).
- ❖ סיום התכנית- הפחתת תדירות הקשר עם ה - link worker באופן הדרגתי.

# תודה
# על ההקשבה

תם הזמן

NEXT...

# קופת חולים מאוחדת

ישי קום, ראש מנהל אזרחים ותיקים

ד"ר גלית סגל, גריאטריה ורפואת משפחה

מאוחדת
רמה אחרת

# היערכות מאוחדת
# לדחיקת דרדור רפואי ותפקודי

# המנהל לאזרחים וותיקים

צוות דחיקת דרדור רפואי ותפקודי – פורום בר"ק - 11.4.24

חט' רפואה

מנהל אזרחים ותיקים 65+

# תכנים

- פיתוח כלים לניהול וטיפול באוכלוסיית הוותיקים:
  - מדד השבריריות MEFI
  - דשבורד אזרחים וותיקים
- מיפוי תוכניות מרכזיות - מופעלות ומתוכננות
- זום אין לתוכנית מרכזית לדחיקת דרדור

# MEFI (Meuhedet Electronic Frailty Index) מדד שבריריות

## כיצד מודדים שבריריות?

- ה-EFI אומץ ע"י משרד הבריאות האנגלי (National Health Society), ואיגוד הגריאטריים באנגליה
- הוא תוקף והוכח כמנבא אשפוז, מיסוד, תמותה
- האינדקס משמש ככלי לסיווג בני 65+ בסיכון לשבריריות
- הוא מורכב מ-35 ליקויים
- האינדקס מחושב כאחוז הליקויים הקיימים מתוך סה"כ הליקויים
- משתנה רציף וחלוקה ל-4 רמות

# מדד שבריריות (Meuhedet Electronic Frailty Index) MEFI

מחלות ; סימפטומים ; תפקוד

| | | |
|---|---|---|
| Activity Limitation | Fall Related | Parkinson's Disease |
| Anaemia and Haematinic Deficiency | Fatigue | Peripheral Neuropathy |
| Anxiety/Depression | Gait Abnormality | Peripheral Vascular Disease |
| Arthritis | Gastro-intestinal Disease | Polypharmacy |
| Atrial Fibrillation | Hearing Impairment | Require For Care |
| Cancer (any except basal cell skin cancer) | Heart Failure | Sleep Disturbance |
| Cerebrovascular Disease | Housebound | Social Vulnerability |
| Chronic Kidney Disease | Hypertension | Thyroid Disease |
| Coronary Artery Disease | Lung Disease | Urinary Incontinence |
| Dementias | Memory and Cognitive Problems | Vision Comorbidity |
| Diabetes | Muscular Wasting | Weight Loss in the past year/Anorexia |
| Dizziness/Vertigo | Osteoporosis | Total: 35 deficits |

# מקורות איסוף המידע ממערכות ה-BI ל-MEFI

**רפואה |** אבחנות ICD-9

**רוקחות |** צריכת תרופות

**אגף הסיעוד |** אומדני סיעוד

**פיזיותרפיה |** אומדן נפילות טיפול ברצפת אגן, התאמת אביזרי ניידות

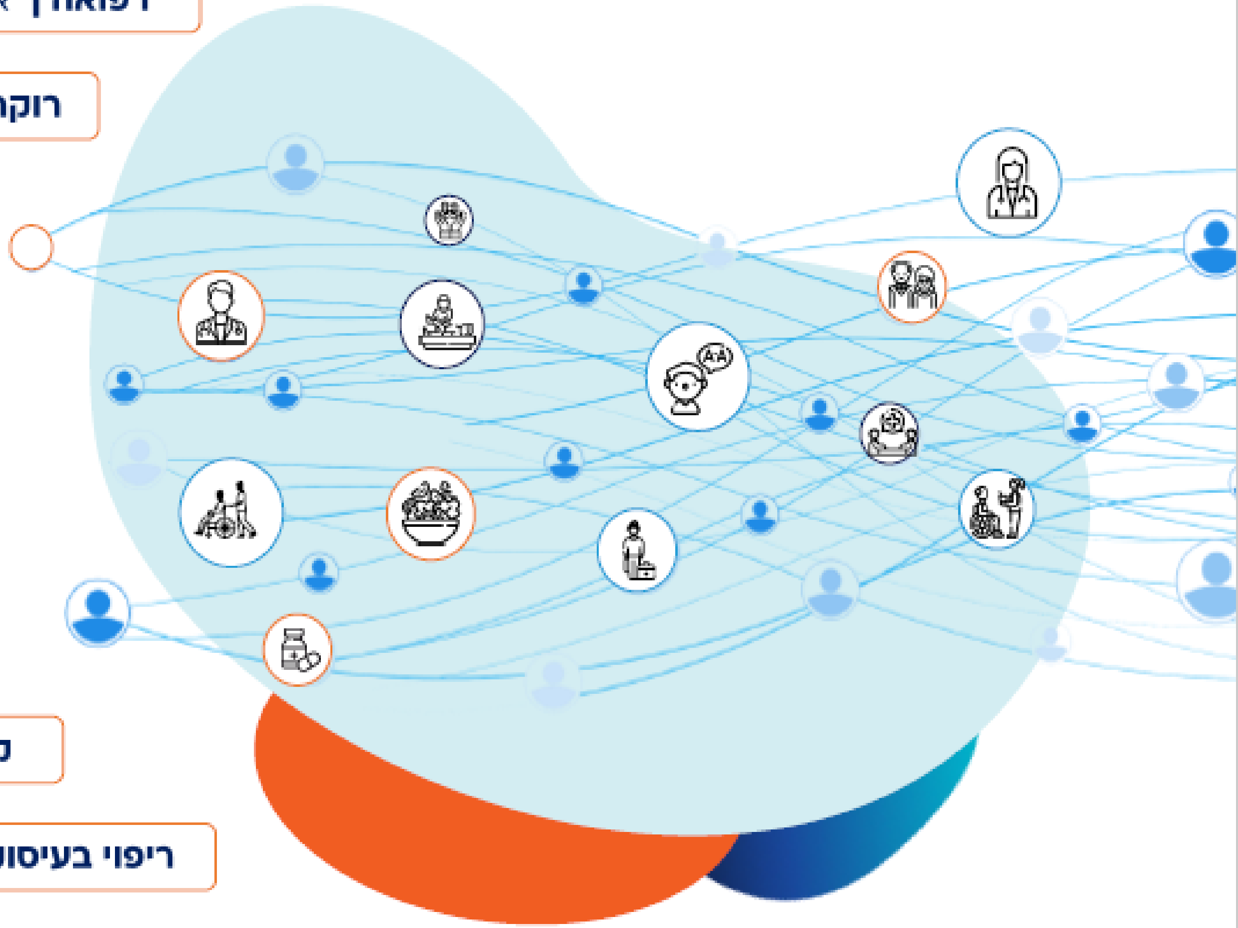
**עבודה סוציאלית |** ניצולי שואה זקנים בעוני

**מנהל אזרחים ותיקים |** מרותקי בית

**תזונה |** ירידה לא רצונית במשקל

**קלינאות תקשורת |** התאמת מכשיר שמיעה

**ריפוי בעיסוק |** טיפול קוגניטיבי – תפקודי, התאמת הבית



גשר לבריאות | מאוחדת רמה אחרת | משרד הבריאות | הג'וינט

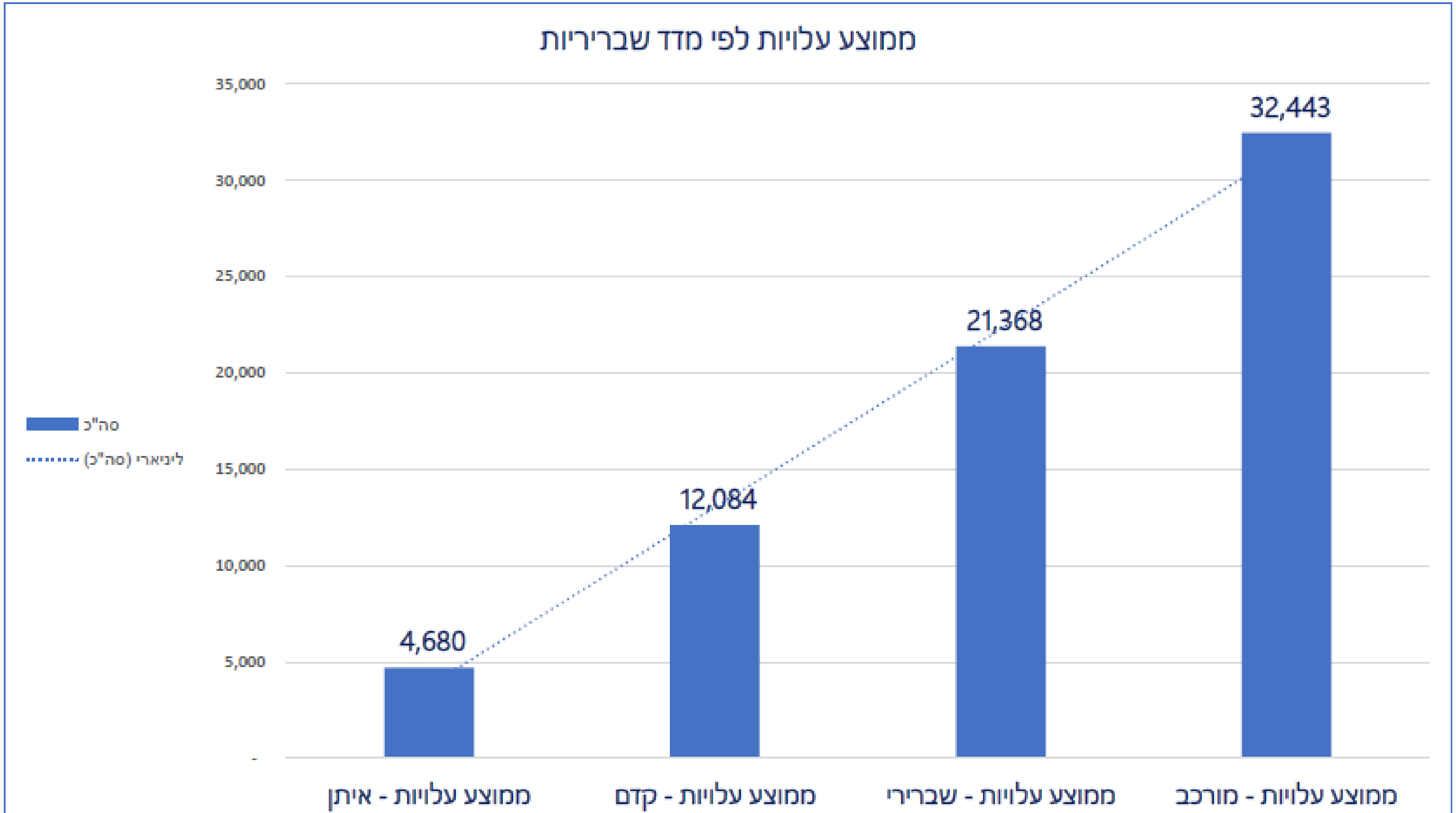
מאוחדת
רמה אחרת

# מפת מדד השבריריות לוותיקים (MEFI)
## Meuhedet - Electronic Frailty Index

| רמת שבריריות (מצב רפואי תפקודי) | איתנים<br>0-4 ליקויים | קדם שבריריים<br>5-8 ליקויים | שבריריים<br>9-12 ליקויים | מורכבים<br>13 + ליקויים |
|---|---|---|---|---|
| סה"כ:<br>N=131,043 | N=55,766<br>42.3% | N=48,090<br>36.5% | N=20,405<br>15.5% | N=7,529<br>5.7% |
| שכבות גילאים | | | | |
| 65-74 | 56.0% | 34.1% | 8.3% | 1.6% |
| 75-84 | 26.8% | 42.7% | 22.6% | 8.0% |
| +85 | 10.3% | 31.7% | 35.6% | 22.4% |

# תחשיב עלויות ממוצעת לאדם ברמה הארצית לפי רמת שבריריות –

## פברואר 23- פברואר 24




הוצאות על:
- אשפוז
- מיון
- מרפאות חוץ
- רפואה קהילתית

# כלי תחקור להתערבות פרואקטיבית
# דשבורד אזרחים וותיקים - ברימון

מוסד גריאטרי
is (All)

רמת שבריריות - MEFI
is (All)

האם היה מגע
is (All)

מחוז לקוח
is (All)

מרחב לקוח
is (All)

מרפאת לקוח
is (All)

עיר לקוח
is (All)

קבוצת גיל
is (All)

אוכלוסיית קשישים בעוני
is (All)

מקבלי גמלאות סיעוד (בטל"א)
is (All)

אוכלוסיית קשישים בודדים
is (All)

ביטוח סיעודי
is (All)

ביטוח מופעל
is (All)

עזרה סיעודית
is (All)

אוכלוסיית מרותקי בית
is (All)

רמת וודאות מרותקי בית
is (All)

אוכלוסיית מאושפזי בית
is (All)

תחלואה גבוהה
is (All)

ניצולי שואה
is (All)

דמנציה
is (All)

מונשם
is (All)

משתחררים מאשפוז בחודש האחרון
is (All)

מרחק מגבול עזה
is (All)

מרחק מגבול לבנון
is (All)

# מיפוי תוכניות מרכזיות קיימות ומתוכננות

מאוחדת
רמה אחרת

| רמת שבריריות (מצב רפואי תפקודי) | איתנים<br>0-4 ליקויים | קדם שבריריים<br>5-8 ליקויים | שבריריים<br>9-12 ליקויים | מורכבים<br>13 + ליקויים |
|---|---|---|---|---|
| סה"כ: | | | | |

**שכבות גילאים:** 65-74 | 75-84 | 85+

**איתנים:**
- סדנאות 65+
- איתור מוקדם לדמנציה
- פעילות לאיתור ומניעת נפילות
- "צ'ק לבריאות" - (ביקור בריא לוותיקים)
- אומדני סיעוד ביו-פסיכו-סוציאלי

**קדם שבריריים:**
- איתור מוקדם לדמנציה
- פעילות לאיתור ומניעת נפילות
- שיקום אמבולטורי ומרחוק
- אומדני סיעוד
- "גשר לבריאות" – התערבות עם קדם שבריריים לאחר אשפוז

**שבריריים / מורכבים:**
- אשפוזי בית | פנימית בית | הוספיס בית | מרותקי בית
- טיפול פליאטיבי
- שיקום אמבולטורי ומרחוק
- רצף טיפול במתמודדים עם דמנציה – מחוז צפון
- **תמיכה והכוונה לבני משפחה – יחידות לאשפוזי בית, מרפאות, דמנציה** (פרטני | קבוצתי | מוקד)
- היענות לטיפול תרופתי
- הנחיות מקדימות וייפוי כח רפואי
- ניהול אוכלוסיות – **COPD**
- "תיאום טיפול" לחולים מורכבים – רווחה וקופה

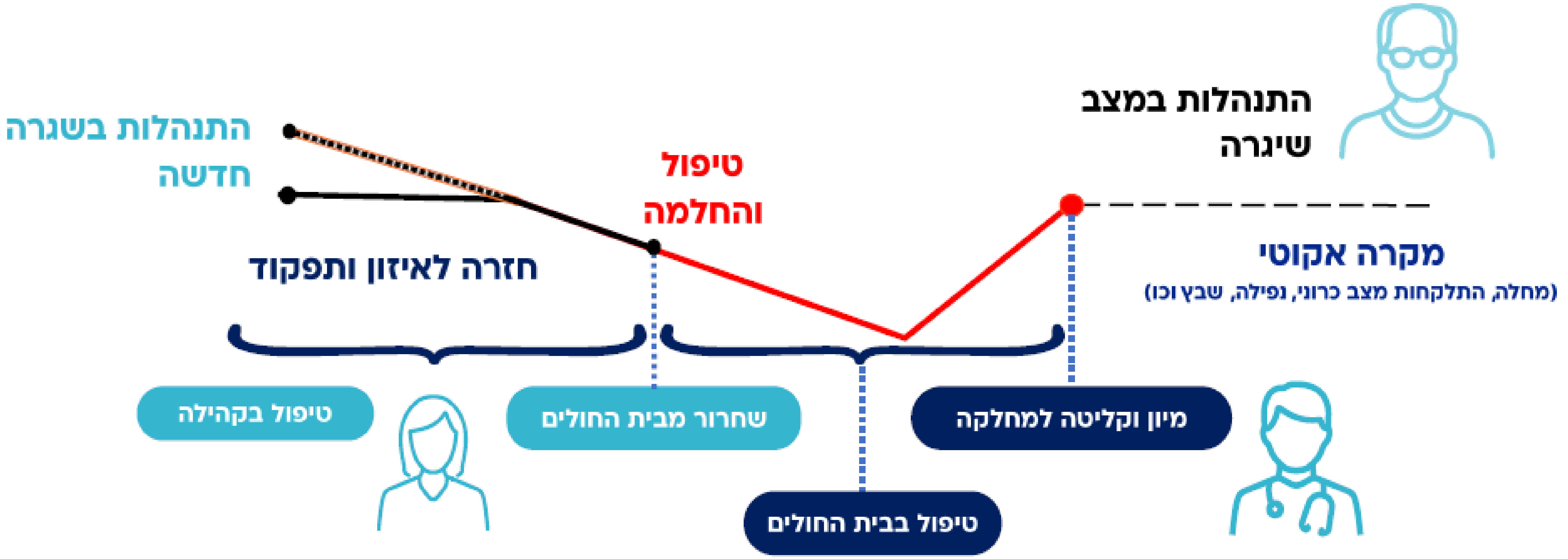
# תוכנית גשר לבריאות מחוז מרכז

פברואר 2024

מנהל אזרחים ותיקים +65

חט' רפואה | חט' כספים | חט' לקוחות | חט' מש"א | חט' תפעול | מחוז מרכז

# תוכנית "גשר" לבריאות: צומת האשפוז – טיפול בבי"ח ובקהילה



# היקף התוכנית

כ-600 מטופלים בשנה,
1,200 בשנתיים

9 מרפאות
במחוז מרכז

מחקר מלווה
הכולל קבוצת ביקורת

# איך זה עובד?

**1**
**איתור**
לאחר האשפוז

**2**
**פנייה אקטיבית**
למטופל בקהילה

**3**
**הערכת צרכים**
**ביו-פסיכוסוציאלית**
**בניית תכנית התערבות**
בדגש על ניהול בריאות עצמי והנעה לאורח חיים בריא

**4**
**הפנייה**
לשירותים פנים וחוץ ארגוניים, סיוע בהסרת חסמים

**5**
**מעקב אחר יישום**
באופן היברידי (פרונטלי, טלפוני)

**6**
**הערכה חוזרת**
וסיום ההתערבות

הג'וינט | משרד הבריאות | מאוחדת רמה אחרת | גשר לבריאות

# מסע מטופל – בקבוצת ההתערבות

**יום לאחר האשפוז**

מטופל קדם שבריירי משתחרר מ -
בי"ח כללי / מיון / שיקום / המשכי באשפוז / פנימית בית

**תוך 3 ימי עבודה**

1. תיאום יזום
למפגש הערכה ע"י מתאמת השרות/ אח/ות גריאטרית

**תוך 7 ימי עבודה**

2. הערכה כוללנית ובניית תוכנית טיפול אישית – אח/ות גריאטרית
רפואה גריאטרית (גיבוי מקצועי)

**תוך 21 ימי עבודה**

**תוך 30 ימי עבודה**

3. רופא משפחה
- אחות מרפאה ראשונית
- עו"ס בהתאם לצורך
- רפואת מומחים ומקצועות הבריאות: רוקחות, פיזיו', ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, תזונה, ברה"נ בהתאם לצורך
- סדנאות קידום בריאות בדגש על שינוי באורח חיים , ניהול בריאות עצמי- בעזרת מתאמת בריאות

קשר עם גורמי חוץ קופתיים בקהילה

מעקב ביצוע התוכנית ע"י האחות הגריאטרית, בסיוע מתאמת שירות ייעודית

**עד 60 ימי עבודה**

4. **הערכה מסכמת** ע"י האחות הגריאטרית, ורצף טיפולי במרפאה הראשונית

הג'וינט | משרד הבריאות | מאוחדת רמה אחרת | גשר לבריאות

# הערכת התוכנית

## מדדים ברמת הפרט

- שיפור תפקודי
- היענות לטיפול
- ניהול בריאות
- שביעות רצון

## מדדים ברמת המערכת

- אשפוזים, אשפוזים חוזרים
- שיעור דרדור תפקודי (MEFI)
- רצף טיפולי פנים ארגוני
- אוריינות בריאות ארגונית
- חיסכון כלכלי

תם הזמן

NEXT...

# הג'וינט-אשל

אורית שחר, מנהלת תחום שיקום ושימור תפקוד

ג'וינט-אשל

# הזדקנות מיטבית

תוכנית עבודה 2024 | מחירום לשיקום ובחזרה לעתיד

# הזדקנות מיטבית

## האימפקט הרצוי

מקסום העצמאות והאוטונומיה של האדם במהלך ההזדקנות

ודחיקת התלות שלו בזולת ובמערכת בגין סיכון בריאותי, חברתי או כלכלי

ובהתאם למדדים להזדקנות מיטבית, בדגש על אוכלוסיות פגיעות.

האימפקט ישאף למקסם את התועלת לאדם ואת התועלת למשק.

[מתוך: התוכנית האסטרטגית ג'וינט-אשל 2021-2025]

# מפת האתגר

## 6 מדדי על

בריאות ותפקוד | משמעות | חוסן כלכלי

## 12 מדדים מנבאים

ניהול בריאות | אורח חיים בריא | אורח חיים חברתי פעיל | מוכנות כלכלית*

## 7 מהלכים

| | | | |
|---|---|---|---|
| בריאות ותפקוד (אשפוז) | מוכנות לתקופת החיים החדשה | שייכות חברתית | תעסוקה איכותית |
| | סיעוד | רשות מקדמת הזדקנות מיטבית | דיור נגיש |

# פריסת תוכניות במהלכים 2024

| הכללה דיגיטלית | מוכנות לתקופת החיים החדשה | תעסוקה איכותית | שייכות חברתית | בריאות ותפקוד (אשפוז) | סיעוד | רשות מקדמת Muni100 | דיור נגיש | תוכניות נוספות (c&o) | תוכניות רוחב באתגר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | סדנאות הכנה לפרישה | | בני משפחה | משגב | | | | ניצולי שואה | |
| | מרכזי 60 + | | קהילה תומכת | | | | | טיפול פליאטיבי | |
| | | | תיאום טיפול | | | | | השיבה הביתה | |
| | | | רשת מקומית | מית"ב בבתי חולים | מטפלים בקהילה | Muni100 | | | בית ספר |
| | | | | תוכניות בקופות חולים | | | | | קהילת חדשנות Aging.il |
| | מרחב וירטואלי | פיתוחים חדשים | מועדונים | | מרכזי יום | | | | |
| | | | מרותקי בית | | מניעה ברמות הסיעוד הנמוכות | | | | |

A בהטמעה　N ביישום　D בפיתוח　בסגירה　הכשרות באמצעות ביה"ס

מהלך

# בריאות ותפקוד (אשפוז)

**רציונאל** | אשפוז הוא גורם סיכון המפר איזון ומביא לירידה תפקודית לאורך זמן אשר עלולה לגרום לשינוי באורח החיים, לירידה באיכות החיים ולעלייה בהוצאות בעלויות הטיפול הבריאותי.

אי לכך, ישנה חשיבות רבה למזעור ההשפעה של אשפוז על רמת התפקוד באמצעות הליכתיות, מניעת דליריום, והתערבות לאחר השחרור בקהילה.

**מטרת המהלך וקהלי יעד** | צמצום ירידה תפקודית הנובעת מאשפוז בקרב בני 65+ טרום שבריריים במהלך אשפוז ובחזרה לקהילה.

**מדדים ברמת הפרט** | צמצום ירידה תפקודית וחזרה לתפקוד לאחר אשפוז.

אשפוז מוכוון תפקוד מסייע בשימור תפקוד ומפחית אשפוזים חוזרים, ובכך מפנה את משאבי בתי החולים לטובת צרכי חירום אחרים.

## תוכניות

| | |
|---|---|
| משגב | מרכזים לשיקום גריאטרי בקהילה העובדים במימון הקופות והמיישמים גישה הוליסטית לשיקום ושימור תפקוד. |
| תוכנית מית"ב בבתי חולים | אימוץ תפיסת "בית חולים ידידותיים גיל" וקידום יישומו בישראל בדגש על הליכתיות ודליריום במהלך אשפוז. |
| תוכניות עם קופ"ח | קידום התנסות בשטח עם קופ"ח מאוחדת 'גשר לבריאות' לאיתור קדם שבריריים לאחר אשפוז ומניעת דרדור במצבם. |

## פעולות רוחב

| | |
|---|---|
| השלמת מפת מדדים | ביצוע תהליך לגיבוש מפת מדדים מוסכמת למהלך. |
| סדנאות ניהול בריאות | הפצת סדנאות והכשרת מכשירים לסדנאות והטמעה באפ 60+ ובקופות החולים בשת"פ עם ביה"ס להזדקנות מיטבית ותחום עצמאים. |
| בחינת מבחני התמיכה הקיימים לשיקום | בחינת מבחני התמיכה הקיימים והתאמה להתמודדות עם בעיית הביקוש. |

## מהלך

# סיעוד

**רציונל |** בישראל עלויות הסיעוד הביתי הן מן הגבוהות במדינות המפותחות. העלייה במספר מקבלי גמלת סיעוד והצרכים המתרבים של אוכלוסייה זו, מצריכים לנקוט בפעולות משולבות של הכשרה מקצועית של המטפלות ויצירת תמריצים במערכת לדחיקת תלות.

למטפל המלווה את במשך שעות רבות במהלך השבוע - פוטנציאל השפעה גדול. לצורך כך נדרש שינוי בתפיסת תפקיד המטפל, הכשרתו, רתימת הענף לשינוי והתאמת תנאי העסקה.

**מטרת המהלך וקהלי יעד |** מערכת הסיעוד תעניק לזקנים שרות מקצועי משמר תפקוד ומקדם עצמאות; באמצעות מערך מטפלות מקצועי ומיומן, שירותים נוספים ותמריצים לדחיקת תלות.

300,000 זקנים, 150,000 מטפלות.

**מדדים ברמת מערכת |** איכות הטיפול, הטמעת תפיסת התפקיד החדשה ומסלולי הקידום, צמצום שיעורי נשירה והגדלת שיעור התמדה

לצד השקעה במטפלות לטובת זקנים במצבי סיעוד מתקדמים, יושם דגש לפיתוח מענים לדחיקת תלות בקרב נדחי חוק סיעוד ודרגות 1-2

## תוכניות

**מטפלים בקהילה**
- פיתוח הכשרה לתפקיד חדש: 'רכז טיפולי' ותפקידים נוספים במדרג; הכשרת 160 מכשירים מחברות סיעוד ו- 5000 מטפלים באמצעות TTT.

**מרכזי יום**
- פיתוח מודל משודרג למרכזי היום לדחיקת תלות וקידום שייכות בתפישת רצף טיפולי.

**מניעה ברמות הסיעוד הנמוכות**
- פיתוח התערבות חדשה לצמצום הדרדרות תפקודית בקרב נידחים וזכאים ברמות הנמוכות.

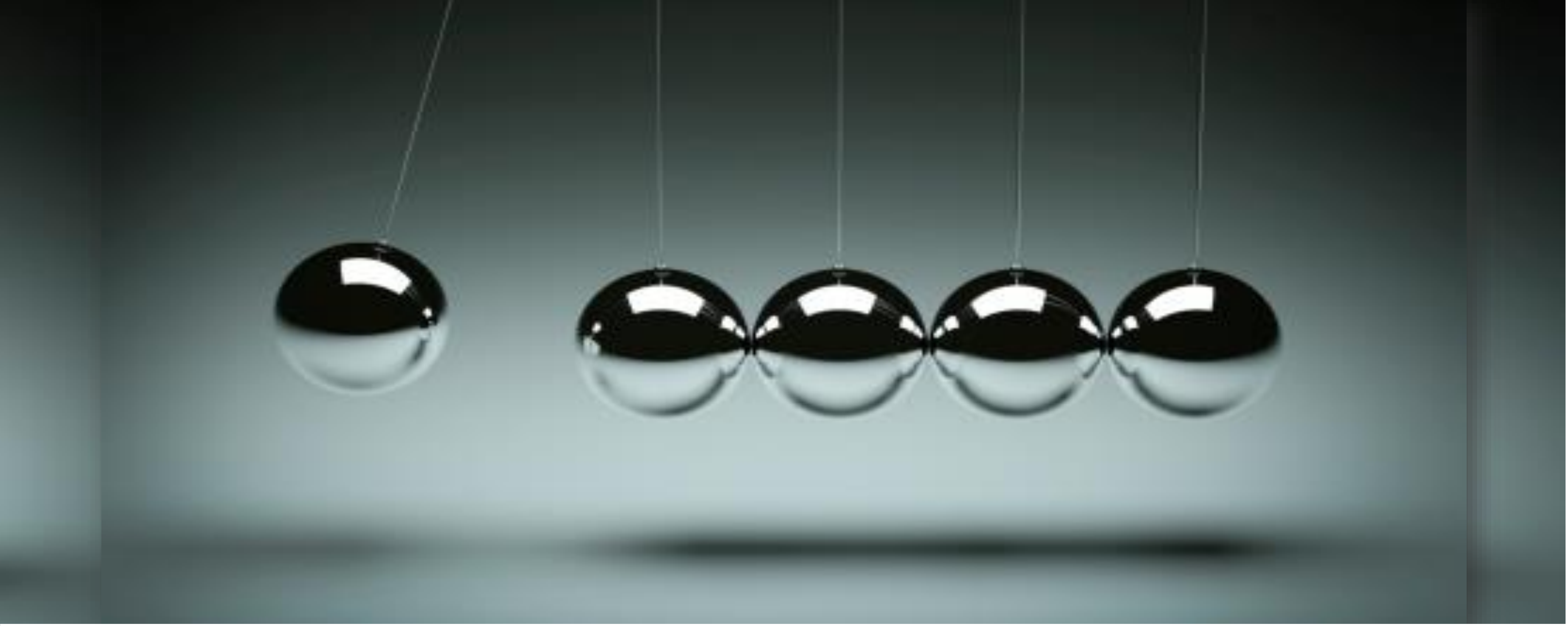
## פעולות רוחב

**השלמת מפת מדדים ותאוריית שינוי**
- השלמת מחקרים להגדרת מדדי מערכת ומחקר חלק ב' לתוצאות ברמת הזקן.

**הכשרת אנשי מקצוע באקו סיסטם**
- הכשרת עובדים מקצועיים בבטל"א ובחברות הסיעוד לתפישה החדשה.

**הסדרת רגולציה, הסמכה ובקרה**
- פרסום אגרת מחייבת להכשרה ובניית מנגנון הכשרה בקרה והסמכה בניהול בטל"א והג'וינט. גיבוש תמריצים בענף.

# ספל ושיח – הפסקה קלה



# תפיסה רב מערכתית משותפת לשימור תפקוד ומניעת הדרדרות

# מטרת התהליך בצוות

תיקוף ודיוק **תפיסה רב**
**מערכתית משותפת** לשימור תפקוד
ומניעת הדרדרות

# חשיבות הנושא של שימור תפקוד למערכות

- רבע מהזקנים במדינת ישראל זכאי חוק סיעוד ונמצאים בצומת קריטית למניעה
- ההוצאה הציבורית על טיפול ובריאות גבוהה וחשוב לנסות לצמצם אותה באמצעות מיקוד במניעה ושימור תפקוד
- תקופה מורכבת המייצרת משבר תקציבי וצורך בשימוש אפקטיבי יותר של המשאבים הקיימים
- מערכות הרווחה והבריאות נדרשות להסיט משאבים מטיפול למניעה

## מורכבות הנושא

- דורש הבנייה וממשק בין שלושת הגופים (ביטוח הלאומי, רווחה ובריאות)
- דורש לדייק את האופן בו המערכות מקדמות שימור תפקוד
- דורש למידה של עולם חדש ועדכון השירותים הקיימים
- דורש לייצר חיבורים וממשקים רב מערכתיים כדי להגיע לקהל היעד ולתת את השירות המתאים בזמן

## נכסים של המשרד בראייה ממשלתית

- יכולת פיתוח שירותים
- נוכחות ופריסה חזקה בשטח
- משרד שיודע לייצר שותפויות
- נגיעה בקהל היעד

# 4 שאלות בבסיס גיבוש התפיסה

### 1. השינוי הרצוי

מהי הבעיה שנרצה לפתור? מהו האימפקט הרצוי? מהו מדד האימפקט?

### 2. הגדרת קהל היעד

בקרב מי נרצה לראות את השינוי? מי נמצא בסיכון/ בצומת מניעה?

### 3. מדדי תוצאה מנבאים ברמת הפרט

איך נראית הצלחה ברמת האדם בקצה?

### 4. יצירת השינוי

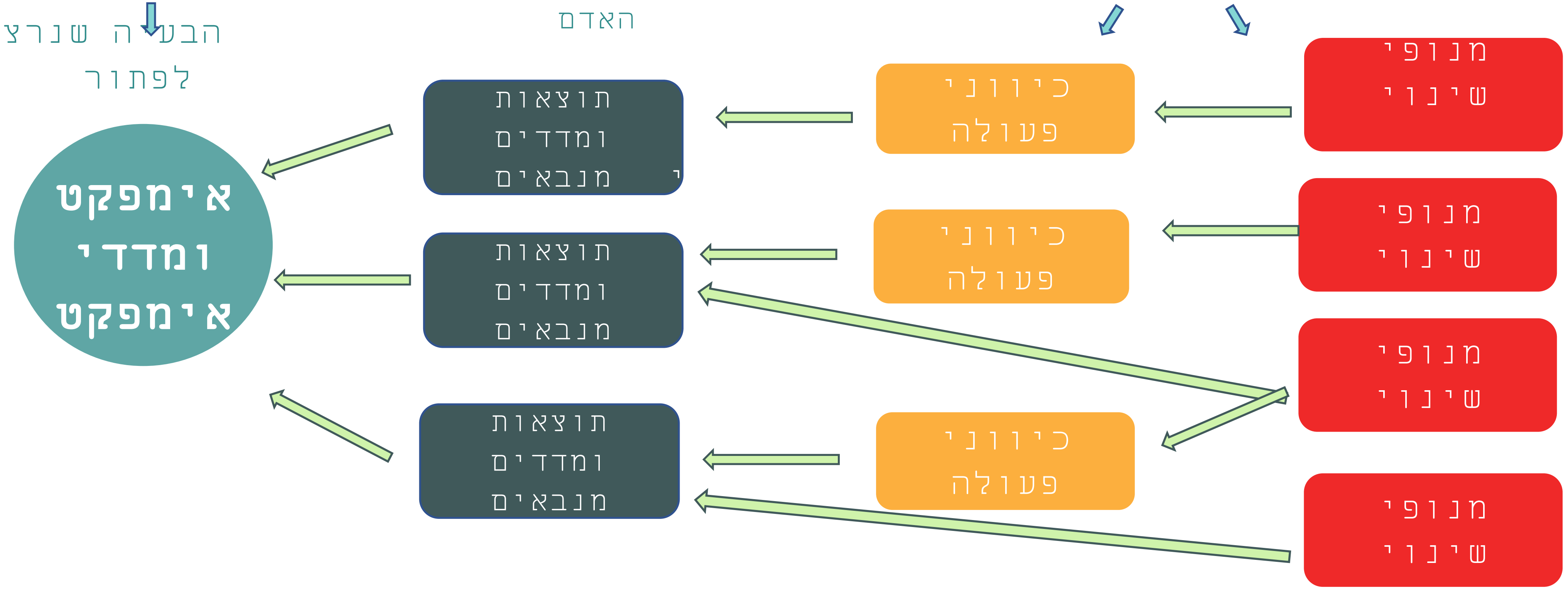
מהם מנופי השינוי וכיווני הפעולה העיקריים?

# סקיצה של מפה אסטרטגית לגיבוש התפיסה

## יצירת השינוי
מנופי שינוי, כיווני פעולה

## מדדי תוצאה ברמת הפרט
איך נראית ההצלחה ברמת האדם

## השינוי הרצוי וקהל היעד
הבעיה שנרצה לפתור



# לאן הולכים יחד....

## הזמנה לשותפות רב מערכתית

תיקוף **המפה עם השותפים**

גיבוש **הסכמות על חלוקת עבודה**

התאמה של **לוח 2ח למניעה**

עיצוב **מערך מדידה**

פיתוח **ממשקים בין המערכות**

הקמת **שולחן עבודה משותף**

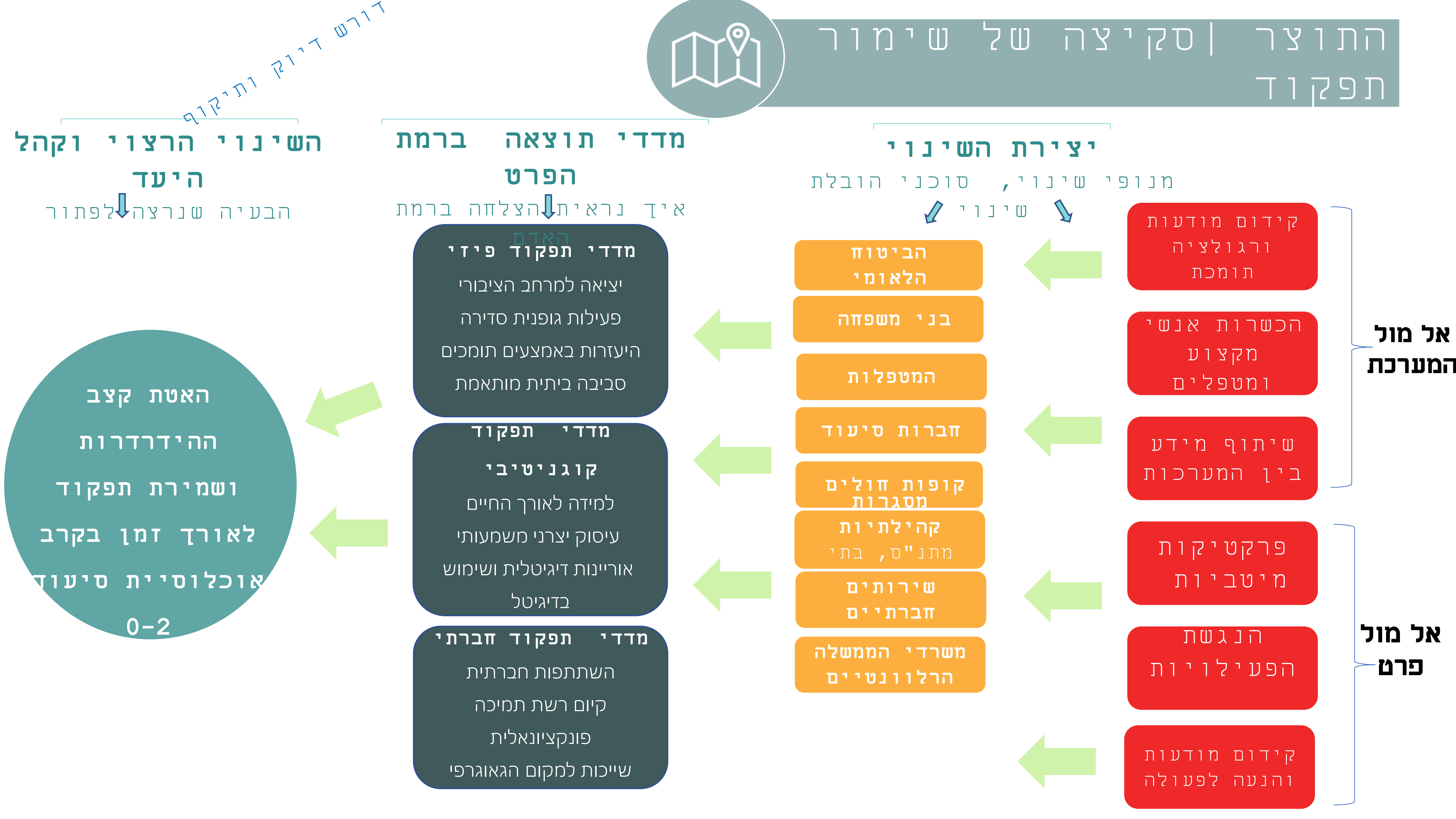
## תוצר רצוי

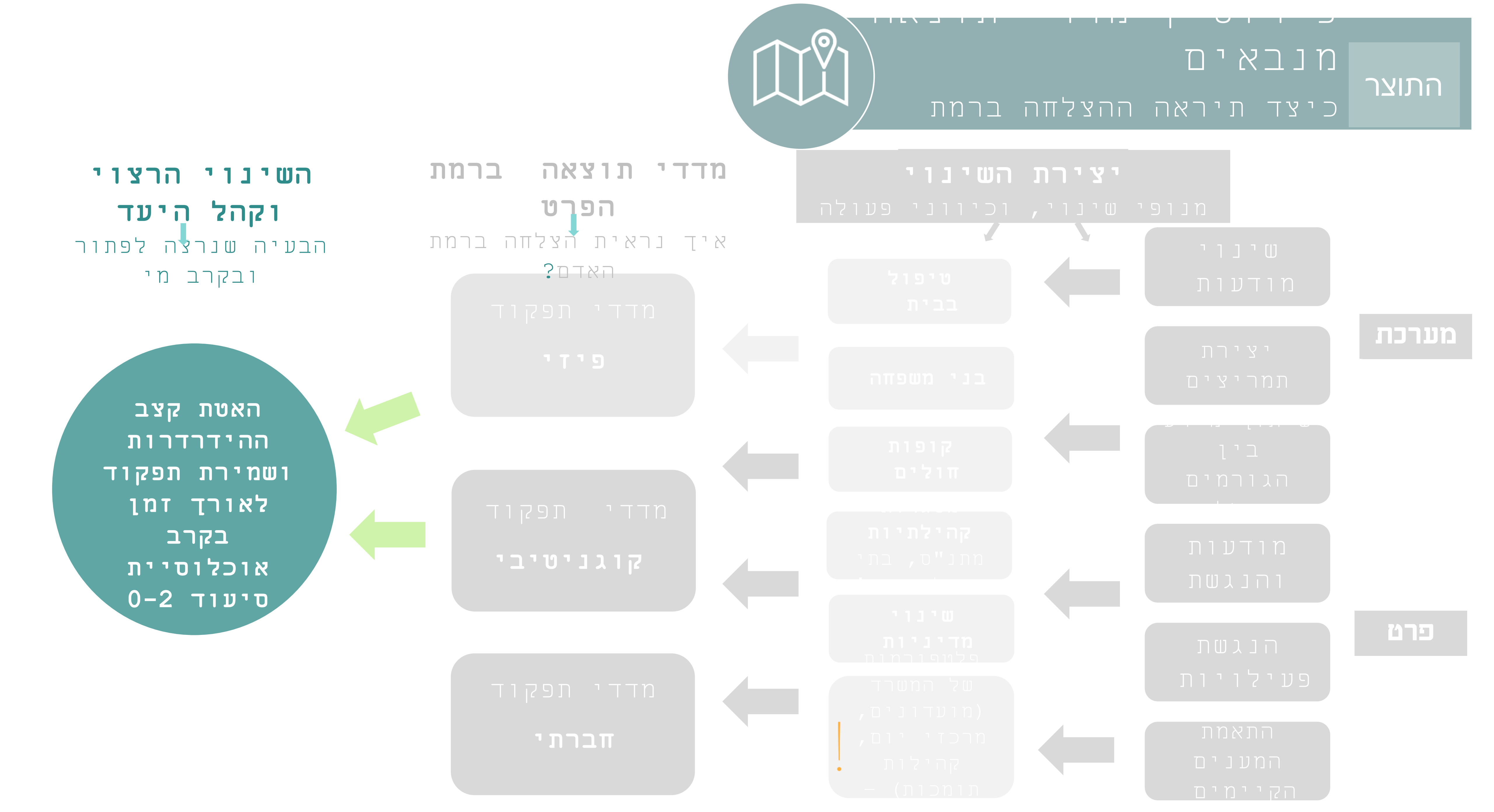
**סקיצה רב מערכתית של מפת שימור תפקוד**

השלמה ודיוק **המפה**

על בסיס **ידע קיים ומחקר משלים**

ושילוב **פרקטיקות מוכחות מהשדה**


התוצר | סקיצה של שימור תפקוד
דורש דיוק ותיקוף
השינוי הרצוי וקהל היעד
הבעיה שנרצה לפתור
האטת קצב ההידרדרות ושמירת תפקוד לאורך זמן בקרב אוכלוסיית סיעוד 0-2
מדדי תוצאה ברמת הפרט
איך נראית הצלחה ברמת האדם
מדדי תפקוד פיזי
יציאה למרחב הציבורי
פעילות גופנית סדירה
היעזרות באמצעים תומכים
סביבה ביתית מותאמת
מדדי תפקוד קוגניטיבי
למידה לאורך החיים
עיסוק יצרני משמעותי
אוריינות דיגיטלית ושימוש בדיגיטל
מדדי תפקוד חברתי
השתתפות חברתית
קיום רשת תמיכה פונקציונאלית
שייכות למקום הגאוגרפי
יצירת השינוי
מנופי שינוי, סוכני הובלת שינוי
הביטוח הלאומי
בני משפחה
המטפלות
חברות סיעוד
קופות חולים מסגרות
קהילתיות מתנ"ס, בתי
שירותים חברתיים
משרדי הממשלה הרלוונטיים
קידום מודעות ורגולציה תומכת
הכשרת אנשי מקצוע ומטפלים
שיתוף מידע בין המערכות
פרקטיקות מיטביות
הנגשת הפעילויות
קידום מודעות והנעה לפעולה
אל מול המערכת
אל מול פרט



התוצר
מנבאים
כיצד תיראה ההצלחה ברמת
יצירת השינוי
מנופי שינוי, וכיווני פעולה
מערכת
פרט
שינוי מודעות
יצירת תמריצים
בין הגורמים
מודעות והנגשת
הנגשת פעילויות
התאמת המענים הקיימים
טיפול בבית
בני משפחה
קופות חולים
קהילתיות
מתנ"ס, בתי
שינוי מדיניות
של המשרד
(מועדונים,
מרכזי יום,
קהילות
תומכות) –
מדדי תוצאה ברמת הפרט
איך נראית הצלחה ברמת האדם?
מדדי תפקוד פיזי
מדדי תפקוד קוגניטיבי
מדדי תפקוד חברתי
השינוי הרצוי וקהל היעד
הבעיה שנרצה לפתור ובקרב מי
האטת קצב ההידרדרות ושמירת תפקוד לאורך זמן בקרב אוכלוסיית סיעוד 0-2

סקיצת
שימור
תפקוד
תובנות

# השינוי הרצוי וקהל היעד

**מדוע נבחר מיקוד בזכאי גמלת סיעוד בדרגות 0-2**

### הזדמנויות הנוצרות מבחירת קהל היעד

- קהל שנמצא בצומת מניעה – פוטנציאל משמעותי לשיפור תפקוד
- הזדמנות למימוש אפקטיבי יותר בתקציב הקיים מול המשבר התקציבי עם המשבר התקציבי
- להתאים את השירותים לאתגרים

### מורכבויות בבחירת קהל היעד

- מדד מנהלי שלא בהכרח משקף את מצב התפקוד ויכול להשתנות מעת לעת
- ההגדרה של זכאי חוק סיעוד עלולה לפספס אוכלוסיות אחרות שנדרשות לשימור תפקוד
- הקושי בהגדרה ודיוק של רמה 0

סקיצת
שימור
תפקוד
פירוט

דורש דיוק ותיקוף

# השינוי הרצוי וקהל היעד

האטת קצב ההידרדרות
ושמירת תפקוד לאורך זמן

## קהל היעד

זכאי חוק סיעוד
ברמות הנמוכות –0
2*

**פרופילים נוספים שסומנו בסדנה :**

- אוכלוסייה בצמתי סיכון ומשבר (פרישה, התאלמנות, אירוע רפואי, וכד')
- התמקדות גילאית (אחרי גיל 75)
- התמקדות באוכלוסייה מוחלשת כלכלית

## מדדי האימפקט

**מדדים אפשריים :**

- גידול במשך הזמן הממוצע במעבר בין רמות הסיעוד ו/או בכניסה לרמת סיעוד
- גידול במשך הזמן הממוצע במעבר בין רמות השברירירות
- מספר שנים בריאות מגיל 65

## התוצר

# מנבאים

כיצד תיראה ההצלחה ברמת

### יצירת השינוי

מנופי שינוי, וכיווני פעולה

**מערכת**

שינוי מודעות

יצירת תמריצים

בין הגורמים

**פרט**

מודעות והנגשת

הנגשת פעילויות

התאמת המענים הקיימים

טיפול בבית

בני משפחה

קופות חולים

קהילתיות מתנ"ס, בתי

שינוי מדיניות

של המשרד (מועדונים, מרכזי יום, קהילות תומכות) –

### מדדי תוצאה ברמת הפרט

איך נראית הצלחה ברמת האדם?

מדדי תפקוד **פיזי**

מדדי תפקוד **קוגניטיבי**

מדדי תפקוד **חברתי**

### השינוי הרצוי וקהל היעד

הבעיה שנרצה לפתור ובקרב מי

**האטת קצב ההידרדרות ושמירת תפקוד לאורך זמן בקרב אוכלוסיית סיעוד 0-2**

סקיצת שימור תפקוד
תובנות

# מדדי תוצאה ברמת הפרט

## מדדים שונים לשימור תפקוד

ישנן מספר שפות מקצועיות להגדרות של מדדי תפקוד:

1. **ביטוח לאומי |תפקוד –** עד כמה האדם מוגבל בביצוע פעולות יומיומיות (ADL) – נבחן דרך גמלת סיעוד
2. **משרד הבריאות |שבריריות** – תואם קריטריונים בריאותיים (מחלות) וגם תפקודיים (יכולות הליכה)
3. **רווחה | שייכות חברתית ומצבי סיכון –** ניתוק חברתי כמגביר מצבי סכנה וסיכון ומשפיע על ותפקודים פיזיים וקוגניטיביים

**יש להכיר בהגדרות השונות ולייצר הסכמות בנוגע למושג ואסטרטגיית המדידה שלו ברמת המדינה וברמת כל מערכת**

סקיצת שימור תפקוד

פירוט

# מדדי תוצאה ברמת הפרט

דורש דיוק ותיקון

**דוגמאות למדדי תפקוד פיזי**

- יוצאים מהבית למרחב הציבורי
- שימוש בעזרים תומכי תפקוד בהתאם לצורך
- ביצוע פעילות גופנית סדירה ומותאמת
- סביבה ביתית מותאמת ובטוחה

**דוגמאות למדדי תפקוד קוגניטיבי**

- לומדים דברים חדשים
- עוסקים בפעילות יצרנית משמעותית
- בעלי אוריינות דיגיטלית ומשתמשים בדיגיטל
- מודעים לחשיבות שימור תפקוד

**תפקוד חברתי**

- השתתפות חברתית
- קיום רשת תמיכה פונקציונאלית
- שייכות למקום הגאוגרפי

# התוצר | סקיצה של שימור תפקוד

דורש דיוק ותיקוף

## יצירת השינוי

מנופי שינוי, נכסי הובלת שינוי

**אל מול המערכת**

- קידום מודעות ורגולציה תומכת
- הכשרות אנשי מקצוע ומטפלים
- שיתוף מידע בין המערכות

**אל מול פרט**

- פרקטיקות מיטביות
- הנגשת הפעילויות
- קידום מודעות והנעה לפעולה

**הביטוח הלאומי**

**חברות סיעוד**

**מטפלות**

**בני משפחה**

**קופות חולים**

**קהילתיות**
מתנ"ס, בתי

**שירותים חברתיים**

**משרדי הממשלה הרלוונטיים**

## מדדי תוצאה ברמת הפרט

איך נראית הצלחה ברמת האדם

**מדדי תפקוד פיזי**
- יציאה למרחב הציבורי
- פעילות גופנית סדירה
- היעזרות באמצעים תומכים
- סביבה ביתית מותאמת

**מדדי תפקוד קוגניטיבי**
- למידה לאורך החיים
- עיסוק יצרני משמעותי
- אוריינות דיגיטלית ושימוש בדיגיטל

**מדדי תפקוד חברתי**
- השתתפות חברתית
- קיום רשת תמיכה פונקציונאלית
- שייכות למקום הגאוגרפי

## השינוי הרצוי וקהל היעד

הבעיה שנרצה לפתור

**האטת קצב ההידרדרות ושמירת תפקוד לאורך זמן בקרב אוכלוסיית**

# פידבקים מהצוות | סקיצה של שימור תפקוד

## יצירת השינוי
מנופי שינוי, סוכני הובלת שינוי

**אל מול המערכת**
- קידום מודעות ורגולציה תומכת
- הכשרות אנשי מקצוע ומטפלים
- שיתוף מידע בין המערכות

**אל מול פרט**
- פרקטיקות מיטביות
- הנגשת הפעילויות
- קידום מודעות והנעה לפעולה

- הביטוח הלאומי
- בני משפחה
- המטפלות
- חברות סיעוד
- קופות חולים
- קהילתיות
  מתנ"ס, בתי
- שירותים חברתיים
- משרדי הממשלה הרלוונטיים

## מדדי תוצאה ברמת הפרט
איך נראית הצלחה ברמת האדם

**מדדי תפקוד פיזי**
- יציאה למרחב הציבורי
- פעילות גופנית סדירה
- היעזרות באמצעים תומכים
- סביבה ביתית מותאמת

**מדדי תפקוד קוגניטיבי**
- למידה לאורך החיים
- עיסוק יצרני משמעותי
- אוריינות דיגיטלית ושימוש בדיגיטל

**מדדי תפקוד חברתי**
- השתתפות חברתית
- קיום רשת תמיכה פונקציונאלית
- שייכות למקום הגאוגרפי

## השינוי הרצוי וקהל היעד
הבעיה שנרצה לפתור

דורש דיוק ותיקוף

**האטת קצב ההידרדרות ושמירת תפקוד לאורך זמן בקרב אוכלוסיית סיעוד 0-2**

# פידבקים מהצוות – המשך |
## סקיצה של שימור תפקוד

### יצירת השינוי
מנופי שינוי, סוכני הובלת שינוי

**אל מול המערכת**

**אל מול פרט**

חשוב להתייחס להגדרה של רמה 0

X כסף לפרט

כסף צבוע לפעולות לדחיקת תלות ולספקיהם

משרד הבינוי והשיכון

### מדדי תוצאה ברמת הפרט
איך נראית הצלחה ברמת האדם

מדדי חוסן

מדדי תהליך לטובת תמרוץ ותגמול

מדדים המתייחסים להיבט הגיאוגרפי

### השינוי הרצוי וקהל היעד
הבעיה שנרצה לפתור

דורש דיוק ותיקוף

האטת קצב ההידרדרות ושמירת תפקוד לאורך זמן בקרב אוכלוסיית סיעוד 0-2

## כיווני עבודה להמשך למפה אסטרטגית משותפת|

- תיקוף המדדים והפרקטיקות המיטביות לשימור תפקוד יתבצע על בסיס ידע מהשדה
- כל גוף יביא לתהליך מידע ונתונים רלוונטיים מהפלטפורמות המרכזיות שבאחריותו
- ישנה חשיבות להנחת בסיס מקצועי משותף לתהליך – הסכמה על תאוריית שינוי, מדדים, פרופילים, התערבויות וכד'
- תרגום המפה לתוכנית יישומית מצריך הסכמות על חלוקת עבודה ומנגנונים לתאום, סנכרון , שיתופי פעולה ומדידה

**תודה לכל המשתתפים.ות**

**על הרעיונות הפוריים**

**ועל הזמן היקר!**

**ממתינים להפגש עמכן.ם שוב**